



EDITORA AGÊNTICA

O DENTISTA GESTOR: FINANÇAS DE CLÍNICA COM IA

PARA INICIANTES

Heverton Eduardo Peres

ESPECIALISTA EM MARKETING E DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES

Heverton Eduardo Peres

O Dentista Gestor: Finanças de Clínica com IA

Obra técnica de literatura especializada, produzida e diagramada conforme as normas ABNT para publicação editorial.

São Paulo
2026

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

P176d PERES, Heverton Eduardo

O Dentista Gestor: Finanças de Clínica com IA / Heverton Eduardo Peres.
– São Paulo : Fábrica Agêntica de Livros,
2026.

; 21 cm.

ISBN 978-65-00000-27-6

1. Dentista. 2. Gestor. 3. Clínica. 4. Finanças. I. Título.

CDD 006.3

Sumário

Capítulo 1: O Dentista que Virou Gestor	8
1. Introdução	8
2. Explica	9
O problema estrutural: formado para clinicar, não para gerir	9
A escala do problema: custos e mortalidade	9
Os números que importam na odontologia	10
Por que a IA gratuita muda o jogo	10
As regras do jogo: conformidade e privacidade	10
3. Ilustra	11
4. Técnica	12
O primeiro controle: a planilha do caixa da clínica	12
Pedindo a planilha ao assistente	12
Automatizando com Python sem instalar nada	13
Classificando despesas com regras (e conferindo com a IA)	13
O retrato da sazonalidade do consultório	14
A projeção simples de caixa (90 dias)	14
A pergunta de calibração	14
Montando a rotina do fim de expediente	15
Estruturando sua pasta de trabalho	15
O retrato do investimento inicial	15
O exemplo do pró-labore na prática	16
A pergunta de investigação de gasto	16
O exemplo da projeção de 90 dias	16
A frase que resume o capítulo	17
O convite para o próximo expediente	17
Kit de verificação do primeiro dia	17
5. Aplica	17
A cena do caos	17
A mesma cena, com o método	18
Exercício do fim de expediente	18
O exercício corrige o rumo	18
6. Conclusão	18
7. Referências	19
Capítulo 2: Os Números da Clínica — Fluxo de Caixa, Ticket Médio e Custos	21

1. Introdução	21
2. Explica	21
O fluxo de caixa: o pulso diário	21
O capital de giro: o colchão da clínica	22
O DRE simplificado: a radiografia mensal	22
O ticket médio: o termômetro do valor	23
O custo da cadeira e a depreciação	23
O pró-labore e a separação das contas	23
O contexto externo: juros, inflação e o mercado de serviços	24
A disciplina da apuração mensal	24
3. Ilustra	24
4. Técnica	26
Montando o DRE simplificado na planilha	26
Automatizando a apuração com Python	26
Cruzando com referências oficiais	27
A planilha de custos da cadeira	27
A análise de sensibilidade: o que acontece se... ..	28
O benchmark com o setor de serviços	28
A tabela de referência do setor	28
O DRE de exemplo, número por número	29
As perguntas que o DRE responde (e as que ele não responde)	29
A leitura de tendência: três meses valem mais que um	30
Precificando com o custo na mão	30
O que evitar no prontuário financeiro	30
A memória de doze meses	31
Kit de verificação do capítulo	31
5. Aplica	31
A cena do caos	31
A mesma cena, com o método	31
Exercício do prontuário financeiro	32
O exercício corrige o rumo	32
6. Conclusão	32
7. Referências	33
Capítulo 3: IA na Bancada — Modelos Gratuitos e Planilhas	34
1. Introdução	34
2. Explica	34
O ecossistema gratuito: cinco caminhos para a mesma bancada	34
A regra de ouro: anonimizar antes de subir	35
O que a IA faz bem (e o que ela faz mal) na gestão da clínica	35
O método do prompt de modelagem	35
A clínica e o Simples Nacional	36

A planilha como linguagem comum	36
3. Ilustra	36
4. Técnica	38
O prompt mestre de modelagem	38
Gerando fórmulas específicas	38
O ciclo de correção dirigida	39
Anonimização: a técnica que libera a nuvem	39
Modelos locais para dados sensíveis	39
Extraindo dados de relatórios e extratos	40
A revisão da planilha como auditoria	40
A política de dados da clínica	41
A tabela de escolha da bancada	41
O prompt de orçamento e planejamento	42
A reunião com o contador: chegar com os números prontos	42
As boas práticas de prompt da bancada	42
Os limites honestos da bancada	43
O primeiro mês da bancada	43
A pergunta que a bancada não responde	43
Kit de verificação do capítulo	43
5. Aplica	44
A cena do caos	44
A mesma cena, com o método	44
Exercício da bancada	44
O exercício corrige o rumo	44
6. Conclusão	45
7. Referências	45
Capítulo 4: Do Caos ao Comando — KPIs, Dashboards e Decisão	46
1. Introdução	46
2. Explica	46
O painel de comando: menos é mais	46
Os KPIs que importam na odontologia	47
O capital de giro e a reserva	47
O contexto: juros, inflação e benchmark	47
A IA como copiloto do painel: interpretar e alertar	48
A conformidade como pilar do comando	48
O plano de 90 dias	48
3. Ilustra	48
4. Técnica	49
Montando o painel de KPIs com Python	49
O semáforo na planilha (fórmulas)	50
O dashboard no Looker Studio	50

O alerta de inadimplência	50
A interpretação mensal com IA	51
A decisão de abrir a terceira cadeira	51
O alerta automático por e-mail	51
A reunião de cinco minutos com o painel	52
O plano de 90 dias, em detalhe	52
O checklist semanal do comando	52
A análise de variação com a IA	53
Os dados que ainda não são financeiros	53
O registro do aprendizado mensal	53
As métricas que comprovam o método	54
O fechamento do arco: da cadeira ao comando	54
O que este livro não é	54
Kit de verificação do capítulo	55
5. Aplica	55
A cena do caos	55
A mesma cena, com o método	55
Exercício do comando	55
O exercício corrige o rumo	56
6. Conclusão	56
7. Referências	56

Capítulo 1: O Dentista que Virou Gestor

1. Introdução

Você terminou a última consulta do dia, tirou o jaleco e pendurou no cabide. A recepção está vazia, a auxiliar foi embora e a clínica fica em silêncio. É nesse momento — o fim de expediente — que a maioria dos dentistas enfrenta a pergunta que nenhuma faculdade preparou para responder: quanto a clínica realmente ganhou hoje? Quanto custa abrir a cadeira pela manhã? O dinheiro que sobrou no caixa é lucro ou é a sua fatura do cartão que ainda não caiu?

Este livro nasce dessa pergunta. O cirurgião-dentista é um dos profissionais mais bem formados do mundo para cuidar da saúde bucal e, ao mesmo tempo, um dos menos preparados para cuidar do próprio negócio. A grade da graduação em Odontologia quase não reserva espaço para empreendedorismo e gestão financeira, e o resultado aparece nas estatísticas: uma parcela significativa das clínicas abre e fecha as portas nos primeiros anos de operação, não por falta de pacientes, mas por falta de controle financeiro [1]. Neste capítulo, você vai entender por que isso acontece, qual é o custo real de uma clínica e por que a IA gratuita — a mesma que cabe no bolso de qualquer celular — pode ser a virada de mesa para o dentista que decide virar gestor.

Ao final deste capítulo, você será capaz de explicar, em uma conversa de corredor, o tripé que sustenta uma clínica saudável: o dinheiro da clínica separado do seu dinheiro (pró-labore), os números na mesa todos os dias (fluxo de caixa) e a decisão baseada em dado, não em sensação. Você também vai conhecer o colega de bancada que vamos usar em todo o livro: a inteligência artificial gratuita, que vai ajudar a montar planilhas, calcular indicadores e organizar o caos financeiro do consultório.

2. Explica

O problema estrutural: formado para clinicar, não para gerir

A formação odontológica é técnica e clínica: anatomia, patologia, materiais, cirurgia, periodontia. O que o curso não ensina é o que acontece depois que o paciente paga a consulta — ou não paga. Estudos acadêmicos sobre a administração de consultórios mostram que a ausência de disciplinas de empreendedorismo na graduação faz com que o dentista negligencie a gestão financeira justamente no momento em que ela mais importa: a abertura do negócio [1]. O resultado é uma rotina conhecida no setor: o profissional trata bem, fideliza pacientes, mas não sabe dizer se está lucrando, porque nunca estruturou um controle de despesas, um fluxo de caixa ou uma previsão de capital de giro [2].

Isso não é falta de inteligência — é falta de ferramenta. A boa notícia é que os processos de administração financeira aplicados a consultórios já estão mapeados e validados na literatura especializada: separação das finanças pessoais das da clínica, controle sistemático de contas a pagar e a receber, apuração mensal do resultado e cálculo da necessidade de capital de giro [2]. O que falta é uma forma acessível de colocar isso em prática — e é exatamente aí que a IA gratuita entra.

A escala do problema: custos e mortalidade

Montar uma clínica exige capital. Os equipamentos essenciais têm preços de referência bem conhecidos no mercado brasileiro: uma cadeira odontológica parte de cerca de R\$ 22.650, uma autoclave custa a partir de R\$ 6.200 e um compressor odontológico sai por volta de R\$ 2.700 [3]. Somando mobiliário, instalações, materiais e adequação sanitária, o investimento inicial de um consultório básico fica entre R\$ 40 mil e R\$ 100 mil — e esse dinheiro precisa ser recuperado pelo fluxo de caixa da operação [3]. É por isso que o custo unitário por sessão é uma conta que todo dentista deveria saber fazer antes de precificar qualquer procedimento [4].

O quadro se agrava quando o consultório cresce: cada cadeira adicional multiplica custos fixos (aluguel, energia, salários, esterilização), e a margem de cada procedimento precisa absorver essa estrutura. A literatura recomenda que os custos fixos fiquem entre 40% e 50% do faturamento bruto [5]. Acima disso, a clínica começa a operar no vermelho mesmo com agenda cheia — um dos fenômenos mais frustrantes do setor, em que o profissional trabalha cada vez mais e ganha cada vez menos.

Os números que importam na odontologia

Existe um conjunto pequeno de indicadores que resume a saúde financeira de uma clínica. O primeiro é o **ticket médio**: o faturamento total dividido pelo número de pacientes atendidos em um período [6][7]. Se o seu ticket médio é baixo, a clínica está faturando com procedimentos de baixo valor agregado ou concedendo descontos excessivos; se é alto, os tratamentos de alto valor estão puxando a receita [6]. O segundo é a **margem de lucro líquida**: clínicas odontológicas eficientes operam com margens entre 20% e 35%, e os desvios vêm, quase sempre, de precificação errada ou de descontos e parcelamentos longos que corroem o rendimento real [8]. O terceiro é a **inadimplência**: o indicador deve ficar abaixo de 5%; taxas acima de 10% exigem ação imediata de cobrança e revisão da política de parcelamento [5].

Há ainda dois conceitos de gestão que a literatura do setor repete: o **pró-labore** e o **capital de giro**. O pró-labore é o salário que o dentista se paga como funcionário da própria clínica — a separação rígida entre o dinheiro da empresa e o dinheiro da família, apontada como a primeira regra da saúde financeira do consultório [9]. O capital de giro é a diferença entre o ativo circulante e o passivo circulante operacional de curto prazo: é o colchão que paga as contas enquanto os parcelamentos dos pacientes não entram no caixa [10]. Uma clínica sem capital de giro é uma clínica que depende do próximo recebimento para respirar — e um atraso de dois meses de um plano odontológico pode derrubar o caixa.

Por que a IA gratuita muda o jogo

A gestão financeira do consultório é feita de tarefas repetitivas e padronizáveis: registrar recebimentos, classificar despesas, montar o fluxo de caixa mensal, calcular o ticket médio, projetar o caixa dos próximos 90 dias. Tudo isso pode ser feito em planilhas — e tudo isso pode ser feito **com a ajuda de um assistente de IA gratuito** que escreve as fórmulas, explica os cálculos e corrige os erros no lugar do dentista.

A IA não substitui a decisão do gestor: ela acelera o trabalho braçal e coloca os números na mesa. E o setor odontológico tem uma característica que torna essa combinação ainda mais poderosa: os dados financeiros de uma clínica são relativamente simples (algumas centenas de lançamentos por mês), cabem em uma planilha e seguem padrões de mercado bem documentados [5][8]. Ou seja, a matéria-prima existe, a ferramenta gratuita existe e o método existe — falta apenas o gestor decidir usar.

As regras do jogo: conformidade e privacidade

Antes de colocar os dados da clínica em qualquer ferramenta, o dentista precisa conhecer as regras. A clínica é um estabelecimento de saúde: o cadastro no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) é obrigatório para o funcionamento regular [11], e os dados dos pacientes — incluindo prontuários, fotos e informações de pagamento — são dados pessoais

sensíveis protegidos pela Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) [12]. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) regula o tratamento desses dados e o uso de IA, com regras específicas para agentes de pequeno porte [13]. A profissão, por sua vez, é disciplinada por normas do Conselho Federal de Odontologia, que também regulam a publicidade e a forma de anunciar valores [14]. Para dimensionar o mercado em que a clínica opera, o gestor pode recorrer à Pesquisa Nacional de Saúde, que monitora o acesso da população aos serviços de saúde no país [15]. Na prática, isso significa uma regra simples que vamos repetir em todo o livro: **dados de pacientes nunca sobem para a nuvem sem anonimização**. Quando precisar de um modelo de IA, o dentista anonimiza o dado antes — e, para dados ainda mais sensíveis, existem os modelos locais que rodam sem sair do computador.

3. Ilustra

Imagine o fim de expediente de uma clínica de sucesso — não a que você imagina, mas a que você vai construir com este livro. O dentista não está mais no corredor olhando a agenda do dia seguinte. Ele está sentado à bancada, diante de uma tela com três janelas abertas: a planilha de fluxo de caixa, o chat de IA e o dashboard de indicadores. Ele não está trabalhando mais: está **examinando o prontuário financeiro da clínica**, com o mesmo cuidado com que examina um dente — procurando cáries de caixa, fissuras de margem e infecções de inadimplência.

Como Gestor de Clínica Odontológica, você vai perceber que a clínica tem dois pacientes: o paciente que senta na cadeira e o paciente que é o próprio negócio. O diagrama abaixo mostra como o dinheiro flui pela clínica — e onde a IA gratuita se encaixa para dar visibilidade a cada etapa.

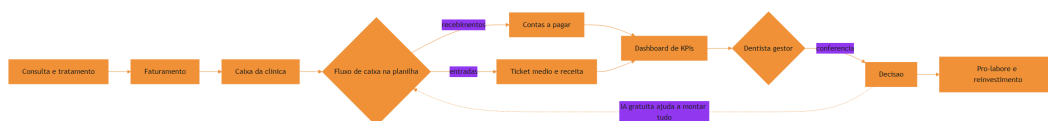


Figura 1: Fluxo financeiro da clínica odontológica com IA gratuita

4. Técnica

O primeiro controle: a planilha do caixa da clínica

Você não precisa de software caro para começar. O primeiro artefato de gestão da sua clínica é uma planilha de fluxo de caixa — e ela pode ser montada em minutos com a ajuda de um assistente de IA gratuito. O método é sempre o mesmo: você descreve o que quer em linguagem natural, o assistente devolve a estrutura e as fórmulas, e você confere o resultado.

Comece criando um arquivo CSV com os lançamentos do mês. Você pode criar esse arquivo no Bloco de Notas, salvando com o nome `caixa_clinica.csv`:

```
Data,Descricao,Categoria,Entrada,Saida
2026-01-05,Consulta limpeza,Procedimento,250.00,
2026-01-08,Restauracao,Procedimento,350.00,
2026-01-10,Compra material,Suprimento,,180.00
2026-01-12,Aluguel,Custo fixo,,3200.00
2026-01-15,Plano odontologico repasse,Plano,4200.00,
2026-01-20,Auxiliar salario,Pessoal,,2400.00
2026-01-25,Implantoproteses,Procedimento,4800.00,
2026-01-28,Conta de energia,Custo fixo,,620.00
2026-01-30,Autoclave manutencao,Equipamento,,450.00
```

Pedindo a planilha ao assistente

Abra o chat do assistente gratuito de sua preferência (ChatGPT, Gemini ou Copilot) e cole este prompt:

```
Atue como um consultor financeiro de clinicas odontologicas.
Vou colar abaixo os lancamentos do fluxo de caixa da minha clinica.
1. Calcule o total de entradas e o total de saidas do mes.
2. Calcule o saldo final do caixa.
3. Separe as despesas por categoria (Custo fixo, Suprimento, Pessoal,
Equipamento).
4. Identifique qual categoria mais consome o caixa.
5. Mostre os calculos passo a passo, sem pular etapas.
```

O assistente devolve os totais e a análise. Antes de aceitar, confira com uma calculadora — a regra de ouro da bancada: **número que não vem com o cálculo não é número, é chute.**

Automatizando com Python sem instalar nada

Para quem quer ir além da conversa, a análise pode ser automatizada com Python — e, mais uma vez, sem instalar nada: os assistentes executam Python no navegador, e o Google Colab também roda gratuitamente. O código abaixo lê o CSV, calcula os totais e aponta a categoria que mais pesa no caixa:

```
import pandas as pd

# Leitura dos lançamentos da clinica
df = pd.read_csv("caixa_clinica.csv")

# Totais de entrada e saida
entradas = df["Entrada"].fillna(0).sum()
saidas = df["Saida"].fillna(0).sum()
saldo = entradas - saidas

# Despesas por categoria
despesas = df.groupby("Categoria")
["Saida"].sum().sort_values(ascending=False)

print(f"Entradas do mes: R$ {entradas:,.2f}")
print(f"Saidas do mes: R$ {saidas:,.2f}")
print(f"Saldo do caixa: R$ {saldo:,.2f}")
print("\nDespesas por categoria (maior -> menor):")
print(despesas.to_string())
```

Classificando despesas com regras (e conferindo com a IA)

Uma das tarefas mais repetitivas da rotina é classificar despesas nas categorias certas. O método em duas etapas funciona assim: primeiro você cria regras simples de classificação, depois pede à IA para aplicar e você confere. Regras típicas de clínica:

```
Classifique cada lançamento pelas regras abaixo e monte uma tabela
Descricao | Categoria:
- Aluguel, condominio, energia, agua, internet -> Custo fixo
- Material de consumo, anestésico, luvas, mascaras -> Suprimento
- Salarios, pro-labore, encargos -> Pessoal
- Manutencao de equipamento, esterilizacao, calibracao -> Equipamento
- Consultas, procedimentos, planos de tratamento -> Procedimento
- Repasses de convenio, operadoras -> Plano
Liste os lançamentos que nao se encaixam em nenhuma regra separadamente.
```

A etapa de conferência é obrigatória: as regras capturam a maioria dos lançamentos, mas a clínica sempre tem exceções — um pagamento de cursos de atualização (que é investimento,

não custo operacional), uma multa (que merece investigação) ou um reembolso. O gestor que confere aprende a enxergar os padrões de gasto da própria clínica; o que não confere importa o viés da ferramenta para dentro do caixa.

O retrato da sazonalidade do consultório

O fluxo de caixa da odontologia não é uma linha reta — tem sazonalidade. Janeiro costuma ser fraco (retorno de férias e gastos de início de ano), março e agosto têm picos de demanda, e o fim de ano concentra a busca por tratamentos estéticos antes das festas. O dentista gestor que conhece a sazonalidade da própria clínica não se assusta com o janeiro fraco: ele sabe que é o mês de repor material, revisar equipamentos e preparar a campanha de março. O primeiro ano de registros cria essa memória; a partir do segundo, a projeção mensal fica confiável.

A projeção simples de caixa (90 dias)

Com três meses de dados, a projeção de caixa vira uma planilha simples: entrada esperada (média do mesmo mês do ano anterior, ajustada pelo crescimento), saídas fixas (aluguel, salários, contas) e saídas variáveis (material, manutenção). O assistente de IA monta a projeção com um prompt direto:

Com base nos meus lançamentos dos ultimos 3 meses (coloquei abaixo), projete o fluxo de caixa dos proximos 90 dias considerando: entradas sazonais (janeiro fraco, marco em alta), saidas fixas mensais e uma reserva de 10% para imprevistos. Aponte os dois meses de maior risco de caixa e sugira uma acao preventiva para cada.

A pergunta de calibração

Antes de confiar na ferramenta para decisões reais, faça a pergunta de calibração — o teste que revela se o assistente calcula ou apenas parece calcular:

Minha clinica faturou R\$ 30.000 no mes e teve R\$ 24.000 de despesas. Qual a margem de lucro? Mostre o calculo completo e depois responda em ate 2 linhas. Se a margem estiver abaixo de 20%, sugira duas alavancas de melhoria.

A resposta correta: margem de 20% $((30000-24000)/30000)$. Se o assistente errar esse cálculo simples, ele não está pronto para os seus números reais — use a resposta dele como diagnóstico de calibração e troque de ferramenta ou refine o prompt.

Montando a rotina do fim de expediente

A disciplina vale mais que a ferramenta. A rotina recomendada é pequena e diária: cinco minutos para registrar os lançamentos do dia (ou pedir para a IA classificar um extrato colado), cinco minutos para conferir o saldo e uma revisão semanal dos indicadores. O objetivo não é perfeição contábil no primeiro mês: é **nunca mais fechar o mês sem saber quanto a clínica ganhou** [2].

Estruturando sua pasta de trabalho

Crie uma pasta no computador (ou no Google Drive) com o nome `gestao_clinica` e dentro dela quatro arquivos: `caixa_clinica.csv` (os lançamentos diários), `contas_a_pagar.csv` (as contas fixas e seus vencimentos), `pacientes_faturamento.csv` (o valor faturado por paciente, sem dados identificáveis) e `kpis_mensais.csv` (os indicadores de cada mês, que o Capítulo 4 vai usar). Essa estrutura simples é a espinha dorsal de toda a gestão financeira do livro.

O retrato do investimento inicial

Para dimensionar a importância do fluxo de caixa, vale olhar o investimento que ele precisa proteger. A tabela abaixo reúne as referências de mercado para um consultório básico de uma cadeira — valores indicativos de 2025/2026, que devem ser atualizados na sua região [7]:

Item	Referência de mercado
Cadeira odontológica	a partir de R\$ 22.650 [7]
Autoclave	a partir de R\$ 6.200 [7]
Compressor	a partir de R\$ 2.700 [7]
Mobiliário, instalações e adequação sanitária	R\$ 10.000–R\$ 30.000 (estimativa)
Material inicial e instrumentos	R\$ 5.000–R\$ 15.000 (estimativa)
Total do consultório básico	R\$ 40.000–R\$ 100.000 [7]

Esse capital precisa ser recuperado pela operação — e é o fluxo de caixa mensal que mostra se a recuperação está acontecendo no prazo planejado. Uma clínica que fatura R\$ 25 mil por mês e retira R\$ 4 mil de pró-labore está recuperando o investimento de R\$ 60 mil a uma velocidade muito diferente da clínica que fatura os mesmos R\$ 25 mil retirando R\$ 10 mil. O gestor precisa ver os dois números todos os meses: quanto a clínica gera e quanto o dono retira.

O exemplo do pró-labore na prática

O pró-labore não é um conceito vago: é um número decidido com método. O cálculo recomendado para começar: (1) some o que você precisa para viver (moradia, transporte, família, lazer — a sua planilha pessoal); (2) divida por 4,3 semanas para o valor semanal e por 21 dias úteis para o diário; (3) compare com o que a clínica pode pagar sem comprometer o capital de giro (a regra: custos fixos entre 40% e 50% do faturamento, pró-labore incluso na análise). Se o necessário é maior que o possível, o desencontro precisa ser enfrentado cedo — com revisão de preços, de despesas ou de agenda — em vez de virar dívida pessoal no cartão [1][9].

A pergunta de investigação de gasto

Quando uma despesa chama a atenção no caixa, o gestor não corta no susto — investiga. A pergunta em três níveis: (1) é recorrente ou pontual? (2) é fixa ou varia com a produção? (3) agrega valor ao paciente ou é só custo? Uma manutenção de autoclave de R\$ 450 é pontual e obrigatória; uma assinatura de software que ninguém usa é recorrente e descartável. O assistente de IA ajuda a montar a tabela de investigação:

Organize minha lista de despesas (coladas abaixo) em uma tabela com as colunas: Despesa, Valor mensal, Recorrente ou pontual, Fixa ou variável, Agrega valor ao paciente? (sim/nao). Depois, aponte as três despesas com maior potencial de redução sem afetar a qualidade do atendimento.

Esse hábito de investigação é o que separa o corte cego do ajuste cirúrgico — a mesma diferença entre arrancar um dente são e tratar a causa.

O exemplo da projeção de 90 dias

Para fechar o capítulo com um exemplo completo, acompanhe a projeção de uma clínica de uma cadeira: custo fixo mensal de R\$ 11.000 (aluguel R\$ 4.500, auxiliar R\$ 3.200, energia e contas R\$ 1.300, pró-labore R\$ 2.000), receita média de R\$ 26.000 com sazonalidade (janeiro -30%, março +15%). A projeção de 90 dias mostra que janeiro, o mês mais fraco, ainda cobre os custos fixos com folga de R\$ 4.000 — mas que a compra de material planejada para fevereiro, se juntada a um atraso de convênio, derruba o saldo abaixo de um mês de custo fixo. A decisão preventiva: antecipar a compra de material para dezembro, quando o caixa está no pico. É exatamente esse tipo de antecipação — ver o risco três meses antes — que o fluxo de caixa bem alimentado permite [2][3].

A frase que resume o capítulo

Se você guardar uma única frase deste capítulo, que seja esta: **o dentista gestor não pergunta quanto entrou, pergunta quanto sobrou e quanto precisa para continuar de pé**. A primeira pergunta se responde no banco; a segunda, no fluxo de caixa; a terceira, no capital de giro [6]. A partir de agora, o seu fim de expediente tem uma nova rotina: cinco minutos, uma planilha, um chat de IA gratuito e a decisão de quem comanda os números — em vez de ser comandado por eles.

O convite para o próximo expediente

Guarde o exemplo da Dra. Mariana: ela não mudou de paciente, de equipamento ou de cidade — mudou o método. Amanhã, no seu fim de expediente, a rotina começa com dez minutos e um arquivo CSV. O convite deste capítulo é simples: feche o dia de hoje sabendo quanto entrou, quanto saiu e quanto sobrou.

Kit de verificação do primeiro dia

Ao final deste capítulo, você deve ter: (1) o arquivo `caixa_clinica.csv` com pelo menos dez lançamentos; (2) o cálculo de entradas, saídas e saldo conferido manualmente; (3) a resposta da pergunta de calibração conferida; e (4) a pasta `gestao_clinica` criada com os quatro arquivos. Nada disso exige pagar por software — apenas o assistente gratuito, uma planilha e dez minutos.

5. Aplica

A cena do caos

São 21h de uma terça-feira. A Dra. Mariana fecha a agenda de 14 pacientes, passa na recepção e pergunta à auxiliar: “quanto entrou hoje?”. A auxiliar não sabe — o pagamento de uns foi em dinheiro, outros no cartão, um parcelado em três vezes. A Dra. Mariana abre o aplicativo do banco: o saldo da conta da clínica é o mesmo da conta pessoal, porque nunca separou. Ela lembra que a fatura do cartão de material vence amanhã e torce para o dinheiro do convênio cair antes. No fim do mês, a contadora liga para dizer que a clínica “deu prejuízo”, e a Dra. Mariana não consegue explicar por quê — ela trabalhou todos os dias.

A mesma cena, com o método

Agora imagine a Dra. Mariana uma estação depois. Ela tem o `caixa_clinica.csv` atualizado, o chat de IA aberto e a rotina do fim de expediente funcionando. Às 21h, ela cola o extrato do dia no assistente e pede: “classifique esses lançamentos nas categorias do meu fluxo de caixa”. O assistente devolve a classificação em segundos; ela confere, aceita e olha o saldo. O pró-labore de R\$ 6.000 já foi transferido para a conta pessoal no dia 5. O ticket médio do mês está em R\$ 310, a inadimplência em 4,8% e a margem em 22% — três indicadores na zona saudável, dois deles com tendência de piora que ela já vê na planilha. A decisão sobre a fatura de material deixa de ser torcida e vira escolha: o caixa cobre, e o capital de giro está em dois meses de custo fixo.

Exercício do fim de expediente

1. Liste as três despesas fixas da sua clínica (ou da clínica que você vai montar) e seus valores mensais.
2. Calcule o ticket médio do último mês: $\text{faturamento} \div \text{pacientes atendidos}$. Se você não tem o número, estime com os dados que tiver.
3. Abra o assistente de IA gratuito e peça: “monte uma planilha de fluxo de caixa para uma clínica odontológica com as colunas Data, Descrição, Categoria, Entrada, Saída e as categorias Procedimento, Plano, Custo fixo, Suprimento, Pessoal, Equipamento. Explique cada coluna.”.
4. Escreva em uma frase qual é o seu pró-labore mensal — se você não tem um, esse é o seu primeiro projeto do livro.

O exercício corrige o rumo

Se você fez o exercício, já percebeu a primeira virada de mentalidade: o dentista gestor não pergunta “quanto entrou hoje?”, pergunta “qual é o meu fluxo e qual é a minha margem?”. A segunda pergunta é muito mais difícil de responder no chute — e muito mais fácil de responder com uma planilha e um assistente de IA gratuitos.

6. Conclusão

Neste capítulo, você viu por que a gestão financeira é o ponto cego da formação odontológica e por que isso custa caro: clínicas fecham não por falta de pacientes, mas por falta de controle [1]. Você conheceu os números que resumem a saúde de um consultório — ticket médio, margem líquida, inadimplência, pró-labore e capital de giro [5][6][8] — e o custo real de montar a

estrutura [3][4]. E você deu o primeiro passo prático: o arquivo de fluxo de caixa, a pergunta de calibração e a rotina do fim de expediente.

O próximo capítulo aprofunda os números da clínica: você vai aprender a ler o fluxo de caixa, a construir um DRE simplificado e a calcular o ticket médio com dados reais do setor — sempre com a IA gratuita na bancada.

7. Referências

- [1] Purcino, G. A. J. et al. A importância da gestão financeira e plano de negócios em clínicas e consultórios odontológicos. E-Acadêmica, 2022. Disponível em: <https://eacademica.org/eacademica/article/view/176>. Acesso em: 08 ago. 2026. [2] Brasil, F. P. et al. Processos de administração financeira em consultórios odontológicos. Revista Fatec Zona Sul (Refas), 2023. Disponível em: <https://www.revistarefas.com.br/RevFATECZS/article/view/634>. Acesso em: 08 ago. 2026. [3] Gnatus. Guia de equipamentos odontológicos essenciais para começar. 2025. Disponível em: <https://www.gnatus.com.br/blog/guia-equipamentos-odontologicos-consultorio/>. Acesso em: 08 ago. 2026. [4] Costa, R. M. et al. Odontoclínica: simulação de gestão em clínica odontológica em um curso de Graduação em Odontologia. Revista da ABENO, 2015. Disponível em: https://revodonto.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1679-59542015000100010. Acesso em: 08 ago. 2026. [5] Odontiva. 10 KPIs Essenciais para Clínica Odontológica. 2026. Disponível em: <https://odontiva.com.br/blog/indicadores-desempenho-clinica-odontologica>. Acesso em: 08 ago. 2026. [6] Dental Office. Dentista: como calcular o ticket médio da sua clínica odontológica? 2024. Disponível em: <https://www.dentaloffice.com.br/ticket-medio/>. Acesso em: 08 ago. 2026. [7] Clinicorp. Como calcular o ticket médio na odontologia? Aprenda agora. 2025. Disponível em: <https://www.clinicorp.com/post/calcular-ticket-medio-odontologia>. Acesso em: 08 ago. 2026. [8] Sanders, L. Como funciona a margem de lucro na odontologia? Simples Dental, 2025. Disponível em: <https://www.simplesdental.com/blog/margem-de-lucro-na-odontologia/>. Acesso em: 08 ago. 2026. [9] CROSP/Sebrae. 41º CIOSP: Planejamento financeiro de clínicas odontológicas foi tema de palestra do Sebrae. São Paulo: CROSP, 2024. Disponível em: <https://crops.org.br/noticia/41-ciosp-planejamento-financeiro-de-clinicas-odontologicas-foi-tema-de-palestra-do-sebrae/>. Acesso em: 08 ago. 2026. [10] Angelus. Como ter uma boa gestão financeira do consultório odontológico? 2024. Disponível em: <https://angelus.ind.br/pt-br/blog/gestao-financeira-de-consultorio-odontologico/>. Acesso em: 08 ago. 2026. [11] Ministério da Saúde/DATASUS. Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES). Disponível em: <https://cnes.datasus.gov.br/>. Acesso em: 08 ago. 2026. [12] Ministério da Saúde. LGPD no setor saúde. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/aceso-a-informacao/lgpd>. Acesso em: 08 ago. 2026. [13] ANPD. Regulamentações — Resoluções de proteção de dados. Disponível em: https://www.gov.br/anpd/pt-br/aceso-a-informacao/institucional/atos-normativos/regulamentacoes_anpd. Acesso em: 08 ago. 2026. [14] Conselho Federal de Odontologia. Portal

institucional — normas e resoluções da profissão. Disponível em: <https://website.cfo.org.br/>. Acesso em: 08 ago. 2026. [15] Ministério da Saúde/IBGE. Pesquisa Nacional de Saúde (PNS). Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias-ms/2026/julho/ministerio-da-saude-e-ibge-iniciam-terceira-edicao-da-pesquisa-nacional-de-saude>. Acesso em: 08 ago. 2026.

Capítulo 2: Os Números da Clínica — Fluxo de Caixa, Ticket Médio e Custos

1. Introdução

No capítulo anterior, você criou o primeiro arquivo de fluxo de caixa e aprendeu a rotina do fim de expediente. Agora é hora de dar profundidade: entender de onde vêm os números, como eles se organizam e o que cada um deles diz sobre a clínica. Um dentista gestor não é um contador — ele não precisa fechar balanços, mas precisa **ler** os números com a mesma segurança com que lê uma radiografia.

Este capítulo ensina três instrumentos de leitura financeira na medida certa para uma clínica odontológica: o **fluxo de caixa** (o pulso diário do dinheiro), o **DRE simplificado** (a radiografia mensal do resultado) e o **ticket médio** (o termômetro do valor que cada paciente agrega). Você vai aprender a montá-los com planilha e IA gratuita, a interpretar os padrões de mercado do setor — custos fixos entre 40% e 50% do faturamento, margem líquida entre 20% e 35%, inadimplência abaixo de 5% [3] — e a cruzar seus números com referências macroeconômicas oficiais para decidir com mais segurança.

Ao final, você saberá responder três perguntas que o banco, o sócio e o seu futuro eu vão fazer: quanto a clínica movimenta, quanto ela custa para ficar de pé e quanto cada atendimento vale de verdade.

2. Explica

O fluxo de caixa: o pulso diário

O fluxo de caixa é o registro de todas as entradas e saídas de dinheiro da clínica, organizado por data. Ele responde à pergunta mais imediata da gestão: **quanto dinheiro existe hoje para pagar as contas de hoje?** A literatura de administração de consultórios recomenda estruturar

esse controle com lançamentos sistemáticos — nada de confiar na memória ou no extrato do banco pessoal [1]. Cada lançamento tem quatro informações: data, descrição, categoria e valor (entrada ou saída).

A diferença entre fluxo de caixa e lucro é crucial e confunde a maioria dos dentistas. O fluxo de caixa enxerga o dinheiro que **entrou e saiu**; o lucro é uma visão contábil que considera receitas e despesas **incorridas**, independentemente de pagamento. Um paciente pode ter feito um tratamento de R\$ 4.800 parcelado em dez vezes: o fluxo de caixa registra R\$ 480 por mês, enquanto o DRE reconheceria o valor do procedimento no mês da entrega. O gestor precisa das duas visões — o caixa para não quebrar, o resultado para saber se está ganhando [1].

O capital de giro: o colchão da clínica

Se o fluxo de caixa é o pulso, o capital de giro é o oxigênio. Ele é calculado como a diferença entre o ativo circulante (o que a clínica tem em caixa, banco e contas a receber de curto prazo) e o passivo circulante operacional (o que ela deve no curto prazo: fornecedores, impostos, salários) [2]. Um consultório que recebe dos planos odontológicos com 45 a 60 dias de prazo, mas paga material e salários todo mês, precisa de capital de giro suficiente para atravessar esse intervalo sem parar de respirar [2].

A regra prática para clínicas pequenas: mantenha capital de giro de pelo menos um a dois meses de custo fixo. Se os custos fixos mensais somam R\$ 15.000, o colchão deve ficar entre R\$ 15 mil e R\$ 30 mil. Abaixo disso, qualquer atraso de convênio vira emergência — e emergência financeira em clínica quase sempre termina em desconto, parcelamento forçado ou empréstimo caro.

O DRE simplificado: a radiografia mensal

O Demonstrativo de Resultado do Exercício (DRE) é o documento que mostra, linha a linha, como a receita se transforma em lucro. A versão simplificada para clínicas tem cinco blocos: **receita bruta** (tudo o que foi faturado no mês), **deduções** (impostos e descontos), **receita líquida**, **custos e despesas** (fixos, variáveis, pessoal, impostos) e **resultado** (lucro ou prejuízo). Cada bloco responde a uma pergunta de gestão: quanto faturou, quanto sobrou depois dos impostos, quanto custou para operar e quanto ficou de resultado [3].

Os padrões de mercado ajudam a ler o DRE da odontologia: os custos fixos devem ficar entre 40% e 50% do faturamento bruto, e a margem de lucro líquida saudável está entre 20% e 35% [3][6]. Quando a margem fica abaixo de 20%, o problema quase sempre está em um de três lugares: precificação (procedimentos subvalorizados), desconto excessivo (pacientes acostumados a negociar) ou custos fora de controle (gastos que cresceram sem revisão) [6].

O ticket médio: o termômetro do valor

O ticket médio é o faturamento total dividido pelo número de pacientes atendidos em um período [4][5]. É o indicador mais rápido de dizer se a clínica está **vendendo tratamento ou vendendo tempo**. Um ticket médio de R\$ 150 indica predominância de consultas e limpezas; um de R\$ 400 indica mix de tratamentos de maior valor (implantes, próteses, ortodontia) [4]. O indicador também expõe a política de preços: desconto demais e parcelamento longo arrastam o ticket para baixo, mesmo com agenda cheia [5].

A leitura do ticket médio nunca deve ser isolada. O gestor cruza o ticket com o volume de pacientes e com a ocupação da agenda: um ticket alto com poucos pacientes pode significar preço acima do mercado; um ticket baixo com muitos pacientes pode significar operação de volume sem margem. O equilíbrio é o ponto em que a clínica maximiza o resultado por cadeira — e é para isso que o Capítulo 4 vai montar o painel de comando [3].

O custo da cadeira e a depreciação

Um erro comum em clínicas é ignorar o custo dos equipamentos na hora de precificar. A cadeira odontológica parte de R\$ 22.650, a autoclave de R\$ 6.200 e o compressor de R\$ 2.700 [7]; somando o restante da infraestrutura, o investimento inicial fica entre R\$ 40 mil e R\$ 100 mil [7]. Esse capital investido não é despesa de um mês: ele se transforma em **depreciação**, o custo de uso do equipamento distribuído ao longo da sua vida útil. Uma cadeira de R\$ 30.000 com vida útil de 10 anos custa R\$ 3.000 por ano, ou R\$ 250 por mês, para a clínica — um custo que existe mesmo quando a cadeira está vazia [7].

Por isso, o custo unitário por sessão — quanto custa, de verdade, abrir a cadeira para um paciente — é uma conta que combina custos fixos rateados, custos variáveis de material e depreciação de equipamento. Dentistas que fazem essa conta descobrem que o “preço de mercado” da limpeza muitas vezes está abaixo do custo real da clínica [8]. É a origem do fenômeno: quanto mais pacientes de procedimento barato, mais rápido o caixa afunda.

O pró-labore e a separação das contas

O pró-labore é o salário que o dentista define para si como gestor — e a regra do setor é enfática: sem pró-labore definido, não há gestão [9]. O dinheiro da clínica e o dinheiro da família devem viver em contas separadas, e o dentista deve se pagar todo mês, como paga a auxiliar. O que sobra depois do pró-labore é o resultado do negócio — e é esse resultado que decide reinvestimento, reserva e crescimento [9].

O contexto externo: juros, inflação e o mercado de serviços

A clínica não opera em uma bolha: a taxa de juros define o custo de um empréstimo para equipar uma terceira cadeira, a inflação corrige o aluguel e os preços de material, e o setor de serviços como um todo dá o parâmetro de crescimento da receita. Essas referências têm fontes oficiais gratuitas: o Banco Central publica séries históricas de juros, inflação e crédito no Sistema Gerenciador de Séries Temporais [10], com dados abertos em formato estruturado para planilhas e ferramentas de análise [11]; o IBGE acompanha mensalmente a receita do setor de serviços na Pesquisa Mensal de Serviços, um benchmark para comparar o faturamento da clínica com o do mercado [12]. Com essas séries, o gestor pode responder, por exemplo: “se a Selic subiu 1 ponto, quanto o meu custo de crédito muda?” — sem depender de achismo [10][11].

A disciplina da apuração mensal

O que transforma esses instrumentos em gestão real é a rotina: apurar o DRE todo mês, no mesmo dia, com os mesmos critérios. Estudos sobre a mortalidade de clínicas apontam o controle mensal de despesas, custos e fluxo de caixa como o principal fator que separa as clínicas que sobrevivem das que fecham [13]. A IA gratuita não elimina a disciplina — ela torna a disciplina barata: classificar lançamentos, montar o DRE e comparar meses leva minutos com um assistente na bancada.

3. Ilustra

O prontuário financeiro da clínica é como um dossiê de exames: cada documento olha para uma dimensão diferente do mesmo paciente — o negócio. O fluxo de caixa é o eletrocardiograma (bate a cada dia), o DRE é a radiografia (revela a estrutura do mês), o ticket médio é o termômetro (mede o valor do atendimento) e o capital de giro é a reserva de oxigênio.

Como Gestor de Clínica Odontológica, você vai olhar para o prontuário financeiro todas as semanas. O diagrama abaixo mostra como os três instrumentos se alimentam dos mesmos dados e convergem para a decisão.

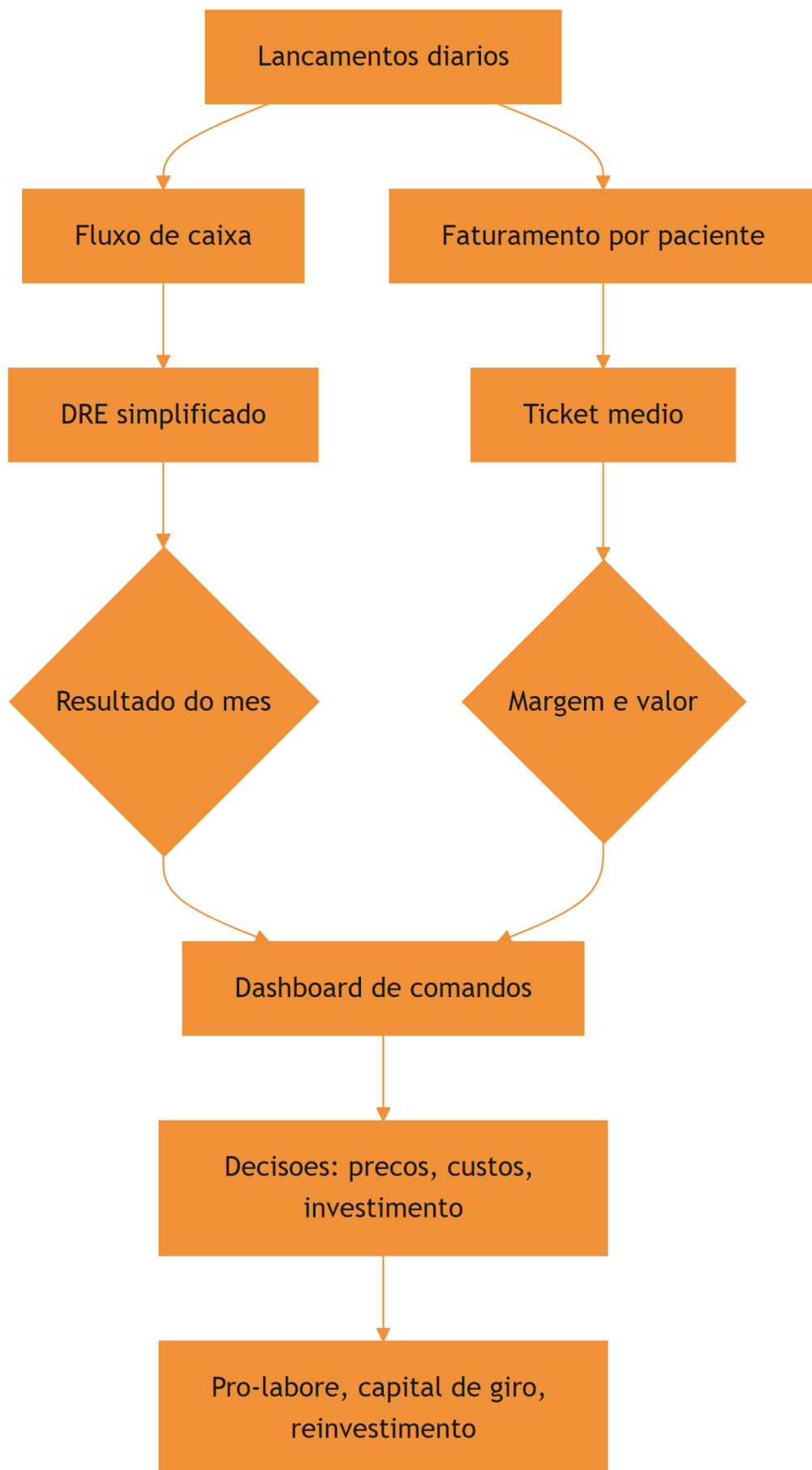


Figura 2: Instrumentos de leitura financeira da clinica

4. Técnica

Montando o DRE simplificado na planilha

Com o arquivo `caixa_clinica.csv` do capítulo anterior, o próximo passo é estruturar o DRE mensal. A forma mais rápida é pedir ao assistente de IA que monte a planilha a partir da sua descrição:

Monte uma planilha de DRE simplificado para uma clinica odontologica com as seguintes linhas e formulas:

1. Receita bruta (soma das entradas de Procedimento e Plano).
2. Deducoes: 8% de impostos sobre a receita bruta (simulacao de Simples Nacional).
3. Receita liquida = Receita bruta - Deducoes.
4. Custos variaveis (Suprimento).
5. Custos fixos (Custo fixo + Pessoal + Equipamento).
6. Resultado = Receita liquida - Custos variaveis - Custos fixos.
7. Margem = Resultado / Receita liquida, em percentual.

Explique cada linha em uma frase.

Automatizando a apuração com Python

Para apurar o DRE e o ticket médio sem digitar nada, use o código abaixo (roda no assistente ou no Google Colab):

```
import pandas as pd

df = pd.read_csv("caixa_clinica.csv")

# Receita bruta: procedimentos + planos
receita_bruta = df[df["Categoria"].isin(["Procedimento", "Plano"])]
["Entrada"].fillna(0).sum()

# Custos
custos_variaveis = df[df["Categoria"] == "Suprimento"]
["Saida"].fillna(0).sum()
custos_fixos = df[df["Categoria"].isin(["Custo fixo", "Pessoal",
"Equipamento"])]["Saida"].fillna(0).sum()

# DRE simplificado
deducoes = receita_bruta * 0.08
receita_liquida = receita_bruta - deducoes
```

```

resultado = receita_liquida - custos_variaveis - custos_fixos
margem = (resultado / receita_liquida) * 100 if receita_liquida else 0

print("=== DRE SIMPLIFICADO ===")
print(f"Receita bruta:      R$ {receita_bruta:,.2f}")
print(f"Deducoes (8%):      R$ {deducoes:,.2f}")
print(f"Receita liquida:      R$ {receita_liquida:,.2f}")
print(f"Custos variaveis:      R$ {custos_variaveis:,.2f}")
print(f"Custos fixos:         R$ {custos_fixos:,.2f}")
print(f"Resultado:           R$ {resultado:,.2f}")
print(f"Margem:               {margem:.1f}%")

# Ticket medio (faturamento por paciente - arquivo sem dados
# identificaveis)
pacientes = pd.read_csv("pacientes_faturamento.csv")
ticket = pacientes["Valor"].sum() / len(pacientes) if len(pacientes) else 0
print(f"\nTicket medio:      R$ {ticket:,.2f} por paciente")

```

Cruzando com referências oficiais

Para comparar a sua margem com o comportamento do mercado de serviços, baixe a série de receita do setor na Pesquisa Mensal de Serviços do IBGE [12] e a série de juros no SGS do Banco Central [10]. O exercício de benchmarking é simples:

Tenho os dados da minha clinica: margem de X%, custos fixos de Y% da receita, ticket medio de R\$ Z. Compare com os padroes de mercado do setor odontologico (custos fixos 40-50%, margem 20-35%, inadimplencia <5%) e com a evolucao da receita do setor de servicos no IBGE. Aponte os tres desvios mais relevantes e uma acao para cada um.

A planilha de custos da cadeira

Monte a conta do custo real por sessão — o número que quase nenhuma clínica conhece:

```

import pandas as pd

# Custos fixos mensais rateados por cadeira
custos = pd.read_csv("contas_a_pagar.csv")
custo_fixo_mensal = custos["Valor"].sum()
numero_cadeiras = 2
sessoes_por_cadeira_mes = 160

# Depreciacao da cadeira (R$ 30.000, 10 anos)

```

```

depreciacao_mensal_cadeira = 30000 / 120

custo_por_sessao = (custo_fixo_mensal / (numero_cadeiras *
    sessoes_por_cadeira_mes)
    + depreciacao_mensal_cadeira / sessoes_por_cadeira_mes)
print(f"Custo fixo por sessao: R$ {custo_por_sessao:,.2f}")
print("(some o material de cada procedimento para o custo total)")

```

A análise de sensibilidade: o que acontece se...

O DRE não responde sozinho às perguntas de gestão; ele responde quando o gestor mexe nas alavancas. A análise de sensibilidade testa cenários: o que acontece com o resultado se o ticket médio subir 10%? Se a inadimplência cair de 8% para 4%? Se o aluguel subir 15% na renovação? O método em planilha é simples: premissas em células separadas (nunca embutidas em fórmulas) e uma aba de cenários que referencia essas células.

Na minha planilha de DRE, crie uma aba de cenários com tres colunas: Realista (premissas atuais), Otimista (ticket medio +10%, inadimplencia -2 pontos, custos fixos -3%) e Pessimista (ticket medio -8%, inadimplencia +3 pontos, custos fixos +5%). Referencie sempre as celulas de premissa da aba principal – nunca valores fixos. Explique como navegar entre os cenarios e qual deles devo usar como base para o planejamento mensal.

A análise de sensibilidade muda a conversa com o sócio e com o banco: em vez de “a clínica vai bem”, o gestor diz “no cenário realista, a margem fica em 24%; no pessimista, em 16% — e a alavanca que mais protege é reduzir a inadimplência”. Número com cenário é decisão; número sem cenário é opinião.

O benchmark com o setor de serviços

Para saber se o crescimento da clínica está acima ou abaixo do mercado, o gestor usa a Pesquisa Mensal de Serviços do IBGE [12]: a variação acumulada da receita do setor é a régua externa. O método é simples: a cada trimestre, comparar o crescimento da receita da clínica com o crescimento do setor no mesmo período. Clínica crescendo abaixo do setor com margem caindo é sinal de problema interno; crescendo abaixo do setor com margem estável pode ser escolha (menos volume, mais valor). O benchmark não decide — ele informa a pergunta certa.

A tabela de referência do setor

Para fixar os padrões, a tabela abaixo resume as referências de mercado discutidas neste capítulo — guarde-a ao lado do painel:

Indicador	Referência saudável	O que indica desvio
Custos fixos / faturamento bruto	40%–50%	acima: estrutura pesada ou preço baixo [3]
Margem líquida	20%–35%	abaixo de 20%: preço, desconto ou custo [6]
Inadimplência	abaixo de 5%	acima de 10%: ação imediata de cobrança [3]
Ticket médio	depende do mix	em queda: mix de baixo valor ou desconto [4][5]
Capital de giro	1–2 meses de custo fixo	abaixo: risco de caixa [2]

O DRE de exemplo, número por número

Para fixar a leitura, acompanhe um DRE completo de uma clínica fictícia de uma cadeira. No mês, a clínica faturou R\$ 32.000 em procedimentos e R\$ 8.000 em repasses de plano — receita bruta de R\$ 40.000. Aplicando 8% de deduções simuladas (faixa baixa do Simples Nacional para serviços), a receita líquida fica em R\$ 36.800. Os custos: R\$ 3.200 de material (suprimento), R\$ 9.000 de salários e encargos da auxiliar, R\$ 6.500 de aluguel e condomínio, R\$ 1.800 de energia e despesas fixas, R\$ 1.200 de manutenção e esterilização, R\$ 900 de pró-labore da recepção terceirizada — total de despesas de R\$ 22.600. Resultado: R\$ 14.200, uma margem líquida de 38,6%. Parece excelente — até o gestor lembrar que ainda precisa pagar o próprio pró-labore de R\$ 8.000 e que a depreciação da cadeira (R\$ 250/mês) não está contabilizada. Ajustado, o resultado real é R\$ 5.950, margem de 16,2% — dentro do amarelo, não do verde. O DRE só conta a história completa quando todas as camadas entram: impostos, depreciação e pró-labore [3][6].

As perguntas que o DRE responde (e as que ele não responde)

O DRE responde: a clínica está ganhando ou perdendo no mês? Qual fatia da receita vai para impostos, custos e despesas? Qual é a margem real? O DRE não responde: quanto dinheiro existe no caixa hoje (isso é fluxo de caixa), qual paciente não pagou (isso é contas a receber), nem se os equipamentos estão sendo usados (isso é ocupação e receita por cadeira). O gestor que mistura os papéis — usar DRE para decidir caixa, ou caixa para decidir margem — toma decisões erradas com documentos certos. A disciplina do prontuário financeiro é usar cada exame para o que ele serve [1][2].

A leitura de tendência: três meses valem mais que um

Um mês isolado é ruído; três meses são sinal. O gestor não decide com base no DRE de um mês — ele olha a tendência: o resultado está subindo, caindo ou estável? O método é simples: montar a tabela de três meses (receita, custos, resultado, margem, ticket, inadimplência) e pedir à IA a leitura:

Compare os tres ultimos meses da minha clinica (tabela abaixo). Para cada indicador, diga se a tendencia e de alta, queda ou estabilidade, quantifique a variacao em percentual e aponte o mes que destoa. Finalize com uma frase: a clinica esta em expansao, estabilidade ou retracao? Justifique com os numeros.

A tendência de três meses também protege contra a reação exagerada: um mês fraco por motivo sazonal (janeiro) não vira pânico, e um mês bom por evento pontual (plano de tratamento fechado) não vira euforia. O prontuário financeiro — como o clínico — acompanha o caso ao longo do tempo, não em uma única foto [1][3].

Precificando com o custo na mão

A precificação baseada no custo — e não no “preço do concorrente” — é uma das maiores viradas deste capítulo. O método em quatro passos: (1) calcule o custo total do procedimento (material + tempo de cadeira + custo fixo rateado por sessão + depreciação); (2) defina a margem-alvo (entre 20% e 35% para o mix saudável [6]); (3) derive o preço mínimo ($\text{custo} \div (1 - \text{margem-alvo})$); (4) compare com o preço de mercado e decida conscientemente: cobrar acima do mínimo financia qualidade e reserva; cobrar abaixo é escolha de captação, desde que o gestor saiba exatamente quanto está sacrificando. O assistente de IA monta a conta:

Calcule o preco minimo de venda de um procedimento com: material R\$ 45, tempo de cadeira 40 minutos (custo da hora da clínica: R\$ 180, incluindo auxiliar, aluguel, energia e depreciação), e margem-alvo de 25%. Mostre o calculo passo a passo e o preco arredondado para valores comerciais. Depois, compare com um preco de mercado de R\$ 280 e explique o que essa diferenca significa para a margem.

O dentista que precifica com o custo na mão negocia de igual para igual com convênios e planos — e sabe, antes de aceitar um desconto, quanto ele custa em margem [6].

O que evitar no prontuário financeiro

Três armadilhas repetem-se nas clínicas e valem um aviso: (1) **misturar contas** — pessoa física e jurídica no mesmo cartão ou conta corrente inviabiliza qualquer leitura; (2) **precificar sem**

custo — o preço baseado no concorrente ignora a estrutura da própria clínica; (3) **medir um mês só** — decisões tomadas com um mês isolado oscilam com a sazonalidade. O prontuário financeiro saudável evita as três: contas separadas, preço derivado do custo e leitura de tendência de três meses [1][3][6].

A memória de doze meses

Ao completar doze meses de prontuário financeiro, o gestor ganha o ativo mais valioso da gestão: a memória do próprio negócio. Com um ano de dados, ele sabe o pico de demanda de março, a fraqueza de janeiro, o comportamento dos convênios e o custo real de cada procedimento — e pode planejar o ano seguinte com números, não com intuição. A IA transforma essa memória em projeção e cenários; o dentista transforma a projeção em decisão.

Kit de verificação do capítulo

Ao final, você deve ter: (1) o DRE do mês apurado e conferido; (2) o ticket médio calculado e comparado com o padrão do setor; (3) o custo por sessão estimado; e (4) uma referência oficial (BCB ou IBGE) anotada no arquivo `kpis_mensais.csv`.

5. Aplica

A cena do caos

O Dr. Carlos tem agenda cheia há três anos. Ele fatura R\$ 45 mil por mês, mas toda vez que precisa trocar um equipamento, precisa “quebrar o galho” — descontar uma fatura no cartão ou pedir ajuda à família. A contadora diz que a clínica é “saudável”, porque o DRE do escritório mostra lucro. O Dr. Carlos não entende por que, com lucro contábil, falta dinheiro no caixa. Ele descobre a resposta no dia em que o convênio atrasa dois repasses: a clínica não tem capital de giro, e o “lucro” contábil está preso em parcelamentos de pacientes que ainda não entraram no caixa.

A mesma cena, com o método

Com fluxo de caixa, DRE e ticket médio na mesa, o diagnóstico aparece em dez minutos. O faturamento de R\$ 45 mil tem R\$ 12 mil presos em parcelas a receber. Os custos fixos somam R\$ 21 mil — 47% do faturamento bruto, dentro do padrão, mas no limite. O ticket médio é R\$

180, abaixo da meta de R\$ 250. O Dr. Carlos toma duas decisões com os dados na mão: cria uma reserva de capital de giro (R\$ 21 mil = um mês de custo fixo) transferindo 10% da receita mensal, e relança o plano de tratamento com precificação revisada, que ele agora consegue justificar com o custo por sessão. Seis meses depois, o ticket médio está em R\$ 235, a reserva montada e a troca de equipamento vira decisão de caixa, não emergência.

Exercício do prontuário financeiro

1. Calcule o seu ticket médio dos últimos três meses e compare com o padrão do setor.
2. Monte o DRE do mês (receita bruta, deduções, custos, resultado, margem) na planilha.
3. Calcule o custo por sessão da sua cadeira.
4. Responda com o assistente de IA: “qual a minha necessidade de capital de giro se meu custo fixo mensal é R\$ X e meus recebimentos de convênio levam 45 dias?”.
5. Registre tudo no `kpis_mensais.csv` — o Capítulo 4 vai transformar esses números em um painel.

O exercício corrige o rumo

A virada deste capítulo é a mudança de pergunta: o dentista gestor não pergunta mais “deu lucro?”, pergunta “deu caixa e deu margem?”. As duas respostas juntas — caixa positivo e margem acima de 20% — são o sinal de que a clínica está viva e crescendo [3][6].

6. Conclusão

Você aprendeu a ler o prontuário financeiro da clínica: o fluxo de caixa como pulso diário [1], o capital de giro como oxigênio [2], o DRE como radiografia mensal [3], o ticket médio como termômetro do valor [4][5] e o custo por sessão como a régua da precificação [7][8]. Você também aprendeu a cruzar os seus números com referências oficiais — juros e crédito no Banco Central [10][11] e o comportamento do setor de serviços no IBGE [12] — e a manter a disciplina da apuração mensal, o fator que a literatura associa à sobrevivência das clínicas [13].

O próximo capítulo coloca a IA gratuita no centro da bancada: você vai aprender a usar modelos gratuitos e planilhas para montar esses controles com prompts eficazes — sem digitar fórmula nenhuma.

7. Referências

- [1] Brasil, F. P. et al. Processos de administração financeira em consultórios odontológicos. Revista Fatec Zona Sul (Refas), 2023. Disponível em: <https://www.revistarefas.com.br/RevFATECZS/article/view/634>. Acesso em: 08 ago. 2026. [2] Angelus. Como ter uma boa gestão financeira do consultório odontológico? 2024. Disponível em: <https://angelus.ind.br/pt-br/blog/gestao-financeira-de-consultorio-odontologico/>. Acesso em: 08 ago. 2026. [3] Odontiva. 10 KPIs Essenciais para Clínica Odontológica. 2026. Disponível em: <https://odontiva.com.br/blog/indicadores-desempenho-clinica-odontologica>. Acesso em: 08 ago. 2026. [4] Dental Office. Dentista: como calcular o ticket médio da sua clínica odontológica? 2024. Disponível em: <https://www.dentaloffice.com.br/ticket-medio/>. Acesso em: 08 ago. 2026. [5] Clinicorp. Como calcular o ticket médio na odontologia? Aprenda agora. 2025. Disponível em: <https://www.clinicorp.com/post/calcular-ticket-medio-odontologia>. Acesso em: 08 ago. 2026. [6] Sanders, L. Como funciona a margem de lucro na odontologia? Simples Dental, 2025. Disponível em: <https://www.simplesdental.com/blog/margem-de-lucro-na-odontologia/>. Acesso em: 08 ago. 2026. [7] Gnatus. Guia de equipamentos odontológicos essenciais para começar. 2025. Disponível em: <https://www.gnatus.com.br/blog/guia-equipamentos-odontologicos-consultorio/>. Acesso em: 08 ago. 2026. [8] Costa, R. M. et al. Odontoclínica: simulação de gestão em clínica odontológica em um curso de Graduação em Odontologia. Revista da ABENO, 2015. Disponível em: https://revodonto.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1679-59542015000100010. Acesso em: 08 ago. 2026. [9] CROSP/Sebrae. 41º CIOSP: Planejamento financeiro de clínicas odontológicas foi tema de palestra do Sebrae. São Paulo: CROSP, 2024. Disponível em: <https://crops.org.br/noticia/41-ciosp-planejamento-financeiro-de-clinicas-odontologicas-foi-tema-de-palestra-do-sebrae/>. Acesso em: 08 ago. 2026. [10] Banco Central do Brasil. Sistema Gerenciador de Séries Temporais (SGS). Disponível em: <https://www3.bcb.gov.br/sgspub/>. Acesso em: 08 ago. 2026. [11] Banco Central do Brasil. Dados Abertos — Séries estatísticas de crédito e serviços. Disponível em: <https://dadosabertos.bcb.gov.br/>. Acesso em: 08 ago. 2026. [12] IBGE. Pesquisa Mensal de Serviços (PMS). Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/servicos/9229-pesquisa-mensal-de-servicos.html>. Acesso em: 08 ago. 2026. [13] Purcino, G. A. J. et al. A importância da gestão financeira e plano de negócios em clínicas e consultórios odontológicos. E-Acadêmica, 2022. Disponível em: <https://eacademica.org/eacademica/article/view/176>. Acesso em: 08 ago. 2026.

Capítulo 3: IA na Bancada — Modelos Gratuitos e Planilhas

1. Introdução

Os capítulos anteriores construíram o prontuário financeiro: fluxo de caixa, DRE, ticket médio e custo por sessão. Chegou a hora de colocar a ferramenta que vai tornar essa rotina leve: a IA gratuita. Este capítulo ensina o dentista gestor a escolher entre os assistentes gratuitos disponíveis (ChatGPT, Gemini, Copilot, Claude), a usá-los para montar planilhas com prompts eficazes e a fazer isso **sem violar a privacidade dos pacientes** — a regra de ouro da bancada.

Você vai aprender o método completo do prompt de modelagem (descrever a arquitetura antes de pedir as fórmulas), o ciclo de correção dirigida (quando a fórmula erra) e a técnica de anonimização que permite enviar dados para a nuvem sem expor ninguém. Para dados ainda mais sensíveis, você vai conhecer os modelos locais — que rodam no computador da clínica, sem sair de casa.

Ao final, você será capaz de montar uma planilha de controle financeiro do zero com IA, conferir cada fórmula, corrigir erros com prompts e decidir com segurança o que pode ir para a nuvem e o que fica local.

2. Explica

O ecossistema gratuito: cinco caminhos para a mesma bancada

A IA gratuita para quem trabalha com finanças de pequenos negócios hoje tem quatro assistentes de nuvem e uma família de modelos locais. O **ChatGPT** analisa planilhas, executa Python no navegador e gera relatórios — é o terminal mais popular da bancada [1]. O **Gemini** integra-se nativamente ao Google Sheets e ao Drive, o que o torna o parceiro natural de quem já vive no ecossistema Google [2]. O **Copilot** trabalha dentro do Office e da web, útil para quem quer gerar fórmulas e resumos sem sair do Word ou do Excel [3]. O **Claude** destaca-se na precisão

lógica, na revisão de código e na análise de documentos longos [4]. Todos têm planos gratuitos com cotas por janela de tempo — para a rotina de uma clínica, que usa a ferramenta em rajadas curtas no fim de expediente, as cotas gratuitas são suficientes na maioria dos meses [1][2].

Há ainda os **modelos locais**: ferramentas como o Ollama executam no computador da clínica modelos de código aberto (famílias Llama, Gemma e Mistral, de 3 a 32 bilhões de parâmetros) que funcionam offline, sem enviar nenhum dado para a nuvem [5]. Eles são mais lentos e menos capazes que os grandes assistentes, mas resolvem tarefas de classificação, resumo e extração — exatamente as tarefas repetitivas da gestão financeira — com privacidade total [5] [6]. Para uma clínica, a combinação vencedora costuma ser: assistente de nuvem para os dados anonimizados e modelo local para o que não pode sair de casa.

A regra de ouro: anonimizar antes de subir

O dado do paciente é um dado pessoal sensível: prontuário, foto, história clínica e forma de pagamento estão protegidos pela Lei Geral de Proteção de Dados, com diretrizes específicas do Ministério da Saúde para o setor [7]. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados regula o tratamento desses dados e o uso de IA, com regras simplificadas para agentes de pequeno porte — a maioria das clínicas se enquadra aí [8]. A regra prática que este livro adota é simples e intransigente: **nenhum dado identificável de paciente sobe para a nuvem**. Antes de qualquer upload, o gestor substitui nomes, CPFs, telefones e endereços por códigos anônimos. Com a anonimização, a análise financeira pode usar toda a potência dos assistentes gratuitos sem risco de vazamento [7][8].

O que a IA faz bem (e o que ela faz mal) na gestão da clínica

A IA gratuita é excelente em tarefas de linguagem e estrutura: transformar uma descrição em uma planilha, escrever uma fórmula a partir de uma pergunta em português, classificar dezenas de lançamentos por categoria, resumir o mês financeiro em três parágrafos, sugerir metas com base em padrões de mercado. Ela é boa, com ressalvas, em contas simples: somas e porcentagens funcionam, mas cadeias longas de cálculo podem escorregar [1]. E ela é perigosamente confiante: quando não sabe, inventa — o fenômeno da alucinação. Na gestão financeira, a consequência é um número errado que vira decisão errada. Por isso, a regra da bancada: **todo número que vem da IA tem que vir com o cálculo — e todo cálculo tem que ser conferido** [1][4].

O método do prompt de modelagem

O erro mais comum do iniciante é pedir a planilha inteira em um único prompt: “monta uma planilha de controle financeiro”. A IA devolve algo genérico, e o dentista aceita. O método profissional divide o processo em duas etapas: primeiro, a **arquitetura** (abas, colunas, premissas

e regras de cálculo — aprovada antes de qualquer fórmula); depois, a **construção** (fórmula por fórmula, explicada e conferida). Esse método, além de produzir planilhas melhores, ensina o gestor a pensar na estrutura do controle antes de preenchê-lo — a mesma disciplina do prontuário financeiro do capítulo anterior [9].

A clínica e o Simples Nacional

Um detalhe de conformidade que aparece nas planilhas: a tributação da clínica. A maioria dos consultórios é microempresa ou empresa de pequeno porte enquadrada no Simples Nacional, cujas regras de apuração unificada de impostos são disciplinadas pela Receita Federal e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional [10]. Ao montar o DRE, o gestor usa uma alíquota simulada de deduções (a faixa do Simples para serviços, que varia conforme o faturamento anual) — e o assistente de IA ajuda a estimar a alíquota a partir do faturamento, mas a confirmação final é com o contador [10]. O prontuário eletrônico e os sistemas de gestão da clínica, por sua vez, dialogam com o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), o registro obrigatório dos estabelecimentos de saúde no Brasil [11].

A planilha como linguagem comum

Na bancada da clínica, a planilha é a linguagem comum entre o dentista, a IA e o contador. O Excel e o Google Sheets são gratuitos (na versão web), aceitam fórmulas em português e exportam CSV — o formato que os assistentes e o Python leem melhor [2]. A combinação vencedora da bancada é: planilha como repositório, IA como copiloto de estrutura e fórmulas, Python (quando necessário) como motor de análise pesada, rodando dentro do próprio assistente ou no Colab — sem instalar nada [1][12].

3. Ilustra

Imagine a bancada do fim de expediente como o painel de uma clínica moderna: no centro, o dentista gestor; à esquerda, a planilha de controle; à direita, o assistente de IA; e, na gaveta, o modelo local para os dados que não podem sair da clínica. Cada ferramenta tem um papel: a planilha guarda, a IA acelera, o modelo local protege e o dentista decide.

Como Gestor de Clínica Odontológica, você vai montar essa bancada em uma tarde — e o diagrama abaixo mostra a arquitetura de dados segura que sustenta tudo.

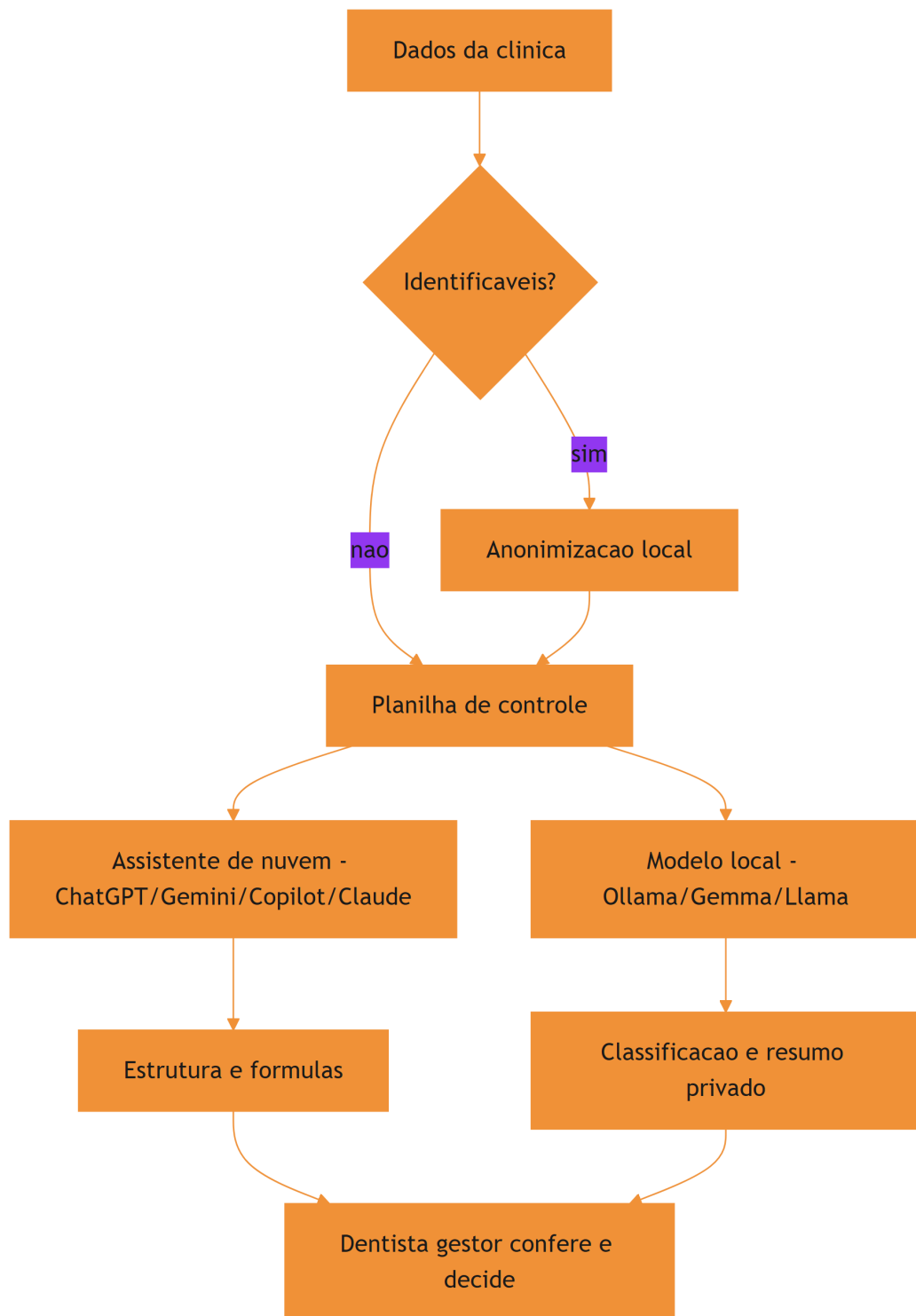


Figura 3: Bancada da clinica com IA gratuita e dados protegidos

4. Técnica

O prompt mestre de modelagem

Abra o assistente gratuito de sua preferência e use este prompt — o mesmo método dos capítulos anteriores, agora com a clínica inteira:

Atue como um consultor financeiro senior de clinicas odontologicas. Antes de gerar qualquer formula, descreva a arquitetura da planilha de [controle financeiro mensal da clinica] que vou construir no Excel. Inclua:

1. As abas necessarias e a funcao de cada uma (ex.: Caixa, DRE, Pacientes, KPIs).
2. As colunas e linhas de cada aba.
3. As premissas que devem ficar separadas das formulas (ex.: aliquota do Simples).
4. As regras de calculo (ex.: ticket medio = receita / pacientes).

Depois de eu aprovar a arquitetura, gere as formulas uma por uma, explicando o que cada uma faz. Nao pule etapas.

O retorno é a arquitetura. Aprove, peça ajustes se precisar, e só então peça as fórmulas. Esse protocolo evita a planilha genérica e ensina a estrutura do controle.

Gerando fórmulas específicas

Com a arquitetura aprovada, gere fórmulas pontuais com prompts de um parágrafo:

No Excel, quero calcular o ticket medio mensal: a receita total (soma da coluna B da aba Caixa, filtrada pelo mes) dividida pelo numero de pacientes atendidos (contagem na aba Pacientes). Escreva a formula, explique o que ela faz e aponte onde usar referencias absolutas.

E para a margem:

Crie uma formula para a margem liquida mensal: resultado dividido pela receita liquida, com o resultado formatado em percentual. A formula deve usar celulas nomeadas (ex.: Resultado_Mes, Receita_Liquida_Mes) em vez de valores fixos.

O ciclo de correção dirigida

Quando a fórmula retorna erro — `#VALOR!`, `#REF!` ou um número que não bate — não comece do zero. Use o ciclo de correção dirigida:

A formula da célula F12 do meu DRE esta retornando `#VALOR!`.
Explique a cadeia de formulas que alimenta F12, identifique a causa mais provavel e proponha a correcao minima, sem alterar as demais células. Mostre a formula corrigida e o que ela faz.

O assistente rastreia a cadeia, aponta o erro e devolve a correção mínima — uma economia enorme de tempo comparada ao Google-Fu de fórmulas [4].

Anonimização: a técnica que libera a nuvem

Antes de enviar qualquer dado da clínica para a nuvem, anonimize. O método rápido com Python:

```
import hashlib
import pandas as pd

# Leitura do arquivo de faturamento com dados de pacientes
df = pd.read_csv("pacientes_bruto.csv")

# Substitui identificadores por codigos hash irreversiveis
df["codigo"] = df["nome"].apply(
    lambda nome: hashlib.sha256(nome.encode()).hexdigest()[:12]
)
df = df.drop(columns=["nome", "cpf", "telefone", "endereco"])

# Mantem apenas o que a analise financeira precisa
df_anon = df[["codigo", "procedimento", "categoria", "valor", "mes"]]
df_anon.to_csv("pacientes_faturamento.csv", index=False)
print("Arquivo anonimizado:", len(df_anon), "linhas, sem dados identificaveis")
```

Com o `pacientes_faturamento.csv` anonimizado, o ticket médio e as análises podem usar a nuvem à vontade [7][8].

Modelos locais para dados sensíveis

Para documentos que você não quer enviar a lugar nenhum — contratos de plano odontológico, termos de parceria, planilhas com valores ainda confidenciais — instale o Ollama e rode um modelo local:

```
# Instala e executa o modelo Gemma 3 (4B) - suficiente para resumos e
classificacao
ollama run gemma3:4b

# Em outra janela, liste os modelos instalados
ollama list
```

Com o modelo local, o prompt de classificação de lançamentos roda sem internet:

```
Classifique cada linha abaixo nas categorias: Procedimento, Plano,
Custo fixo, Suprimento, Pessoal, Equipamento.
[cole os lancamentos do dia]
Responda em formato de tabela com as colunas Descricao e Categoria.
```

Extraindo dados de relatórios e extratos

Outra tarefa em que a IA economiza horas: extrair dados estruturados de documentos não estruturados. O extrato do cartão de material, o resumo do plano odontológico e o relatório da operadora chegam em formatos diferentes — e o assistente transforma tudo em uma tabela padronizada:

```
Cole abaixo o texto do resumo da operadora. Extraia em formato de
tabela com as colunas: Paciente (codigo, sem nome), Procedimento,
Data, Valor repassado, Status (pago/pendente). Normalize os valores
para o formato numerico brasileiro. Aponte qualquer linha ambigua
que precisar da minha confirmacao.
```

O mesmo prompt serve para extratos bancários, notas de material e relatórios de agenda. A regra vale de novo: dados identificáveis são anonimizados antes; e cada linha extraída merece uma conferência amostral — a IA erra linhas, nunca a estrutura inteira.

A revisão da planilha como auditoria

Depois de montar a planilha, use a IA como auditora — o mesmo ciclo de correção dirigida, agora aplicado ao conjunto:

```
Revise minha planilha de controle financeiro como um controller senior.
Aponte: (1) formulas com valores fixos embutidos que deveriam ser
premissas; (2) celulas sem referencias absolutas que podem quebrar ao
arrastar; (3) categorias de lancamento inconsistentes; (4) indicadores
que podem ser calculados errado por causa da estrutura. Para cada
achado, sugira a correcao minima. Nao altere nada sem me mostrar antes.
```


Essa auditoria periódica (a cada trimestre) mantém a planilha saudável conforme a clínica cresce — novas categorias, novas cadeiras, novos convênios.

A política de dados da clínica

Para fechar a governança, a política de dados da bancada deve ficar escrita e visível (na recepção e na pasta de gestão):

Redija uma politica de uso de IA para a clinica odontologica com 5 itens: (1) quais dados podem ir para assistentes de nuvem e quais exigem modelo local; (2) a obrigacao de anonimizacao antes de qualquer upload; (3) a regra de conferencia humana de todo numero antes de qualquer decisao; (4) quem e o responsavel pela bancada; (5) o que fazer em caso de suspeita de vazamento. Linguagem pratica, maximo 30 linhas.

A política não é burocracia: é o que protege a clínica na prática — e o que o gestor mostra, com segurança, para pacientes e para a ANPD se algum dia for perguntado [8].

A tabela de escolha da bancada

A escolha da ferramenta não precisa ser religiosa — é funcional. A tabela abaixo resume o papel de cada opção gratuita na bancada da clínica:

Ferramenta	Melhor papel na clínica	Limite típico do gratuito
ChatGPT	Análise de planilhas, Python no navegador, relatórios [1]	Cota de mensagens por janela
Gemini	Integração com Sheets e Drive da clínica [2]	Cota de mensagens e contexto
Copilot	Fórmulas e resumos dentro do Office [3]	Cota diária
Claude	Revisão de código e documentos longos [4]	Cota semanal
Ollama + Gemma/Llama	Dados sensíveis, offline, classificação [5][6]	Hardware da clínica

A regra de bolso: o trabalho com dados anonimizados pode usar qualquer assistente de nuvem; o trabalho com dados identificáveis ou contratos confidenciais fica com o modelo local [5][7][8].

O prompt de orçamento e planejamento

A bancada também serve para o planejamento — o orçamento anual da clínica, que conversa com o Capítulo 2 e o Capítulo 4:

Monte o orçamento mensal da clínica para os próximos 12 meses com base nos dados dos últimos 3 meses (colados abaixo). Premissas: (1) crescimento de receita de 5% ao ano, sazonal (janeiro fraco, março e agosto em alta); (2) custos fixos corrigidos pela inflação de 4% ao ano; (3) meta de inadimplência abaixo de 5%; (4) reserva de capital de giro de 1 mês de custo fixo até o mês 6. Aponte os três meses de maior risco de caixa e o mês em que a reserva fica completa.

O orçamento resultante alimenta o painel do próximo capítulo — e a comparação mês a mês entre o orçado e o realizado vira o indicador de gestão mais completo da clínica.

A reunião com o contador: chegar com os números prontos

Um dos maiores ganhos da bancada é a mudança na relação com o contador. Em vez de levar caixas de papel ou prints de planilhas, o gestor chega com um resumo executivo gerado e conferido — e o contador passa de “tradutor de caos” a consultor de verdade. O prompt de preparação:

Prepare um resumo executivo de uma página para a reunião com o contador, com: (1) DRE simplificado dos últimos 3 meses em tabela; (2) principais indicadores (margem, ticket, inadimplência, custos fixos); (3) três dúvidas objetivas sobre tributação do Simples Nacional para a minha faixa de faturamento; (4) uma lista de documentos que devo levar (extrato, notas, comprovantes). Tom profissional e direto.

Chegar com os números prontos muda a conversa: o contador responde dúvidas e orienta, em vez de passar a reunião inteira levantando dados. E a pergunta sobre a alíquota correta do Simples Nacional — a faixa exata depende do faturamento anual e muda todo ano [10] — vira uma pergunta objetiva com a resposta na ponta do lápis.

As boas práticas de prompt da bancada

Seis hábitos separam o prompt que funciona do prompt que frustra: (1) **dê o papel** — “atue como um consultor financeiro de clínicas”; (2) **dê o contexto** — “clínica de uma cadeira, faturamento médio de R\$ 28 mil”; (3) **peça a estrutura** — “responda em tabela com as colunas X, Y, Z”; (4) **peça o cálculo** — “mostre o passo a passo”; (5) **peça o limite** — “aponte o que você não consegue concluir com esses dados”; (6) **exija o formato de saída** — “no máximo 20 linhas”.

Um prompt bem construído reduz drasticamente o retrabalho e as alucinações — e o dentista gestor melhora os próprios prompts mês a mês, registrando os que funcionam [1][4].

Os limites honestos da bancada

A bancada de IA tem limites que o gestor deve conhecer para não ser enganado pela fluência: a IA **não sabe** os dados da sua clínica (você precisa fornecê-los, anonimizados); a IA **pode errar** contas longas (confira sempre o cálculo); a IA **pode inventar** fontes e números (peça referências e verifique); a IA **não conhece** a sua realidade local (preços, convênios, região — o contexto é seu). A mentalidade correta é a do copiloto: a IA acelera, o piloto decide. Quem trata a IA como oráculo transfere para a ferramenta o erro que é humano [1][4][8].

O primeiro mês da bancada

O primeiro mês de uso da bancada não precisa ser perfeito — precisa ser registrado. A meta realista: classificar os lançamentos do mês com a IA, montar uma planilha de controle com arquitetura aprovada, anonimizar um arquivo de pacientes e rodar ao menos uma tarefa sensível no modelo local. Ao final do mês, o gestor revisa o que funcionou e o que travou, ajusta os prompts e amplia o escopo no mês seguinte. A bancada cresce com a clínica — a ferramenta muda, o método permanece.

A pergunta que a bancada não responde

Vale lembrar o que a bancada não faz: ela não substitui a contadora nem o CFO — a apuração fiscal, a folha de pagamento e o fechamento contábil continuam com o profissional habilitado. A bancada é o camada de gestão que fica entre a clínica e o escritório: organiza, mede e orienta, para que o contador e o dentista conversem sobre decisões, não sobre papelada [10].

Kit de verificação do capítulo

Ao final, você deve ter: (1) a arquitetura da planilha de controle aprovada com a IA; (2) as fórmulas de ticket médio e margem geradas e conferidas; (3) o `pacientes_faturamento.csv` anonimizado; (4) pelo menos uma tarefa rodada no modelo local (se instalou o Ollama); e (5) a decisão documentada de quais dados podem ir à nuvem e quais ficam locais.

5. Aplica

A cena do caos

A Dra. Renata quer montar o controle financeiro da clínica. Ela copia a planilha “pronta” que uma colega compartilhou e começa a preencher. Na terceira semana, percebe que as fórmulas não batem: a planilha foi feita para outra realidade, com categorias diferentes e valores fixos embutidos. Pior: ela colou no chat de IA o arquivo `pacientes.xlsx` original — com nomes, CPFs e fotos de prontuário — pedindo “análise”. O assistente analisou, e a Dra. Renata só depois pensa no que acabou de fazer: enviou dados sensíveis de pacientes para a nuvem, sem anonimizar [7][8].

A mesma cena, com o método

A Dra. Renata recomeça com o método: primeiro, o prompt de arquitetura; a IA devolve as abas Caixa, DRE, Pacientes e KPIs, com premissas separadas; ela aprova. Depois, as fórmulas uma a uma, conferidas com a calculadora. Antes de qualquer upload, ela roda a anonimização: o `pacientes_faturamento.csv` sai com códigos no lugar de nomes. O que precisa de análise pesada vai para a nuvem; o que é confidencial fica no modelo local. No fim do mês, a planilha está de pé, o DRE fecha com a calculadora e nenhum dado sensível saiu da clínica.

Exercício da bancada

1. Abra o assistente gratuito e rode o prompt mestre de modelagem para o seu controle financeiro.
2. Aprove a arquitetura (ou peça ajustes) e gere a fórmula do ticket médio.
3. Anonimize uma planilha de pacientes de exemplo com o código do capítulo.
4. Se tiver um dado confidencial, rode a classificação de lançamentos no modelo local (Ollama).
5. Escreva em uma linha: “o que pode ir à nuvem e o que fica na clínica” — e cumpra.

O exercício corrige o rumo

A virada deste capítulo é a mentalidade de copiloto: a IA monta, o gestor confere; a nuvem acelera, a anonimização protege. A clínica ganha velocidade sem perder a guarda dos dados — a combinação que o próximo capítulo vai transformar em um painel de comando completo.

6. Conclusão

Você conheceu o ecossistema gratuito da bancada — ChatGPT, Gemini, Copilot e Claude na nuvem [1][2][3][4], modelos locais para o que não pode sair da clínica [5][6] — e o método para extrair valor de cada um: o prompt de arquitetura, a fórmula por fórmula, o ciclo de correção dirigida e a anonimização como passaporte para a nuvem [7][8]. Você também alinhou a bancada com a conformidade: Simples Nacional na tributação [10] e CNES no registro [11]. A ferramenta agora está montada — falta transformar os números em comando visual, o tema do próximo capítulo.

7. Referências

[1] OpenAI. ChatGPT — Análise de dados e execução de código no navegador. Disponível em: <https://openai.com/chatgpt/>. Acesso em: 08 ago. 2026. [2] Google. Gemini — integração com Google Workspace (Sheets e Drive). Disponível em: <https://gemini.google.com/>. Acesso em: 08 ago. 2026. [3] Microsoft. Copilot — assistência no Microsoft 365 e na web. Disponível em: <https://copilot.microsoft.com/>. Acesso em: 08 ago. 2026. [4] Anthropic. Claude — precisão lógica e revisão de código. Disponível em: <https://www.anthropic.com/claude>. Acesso em: 08 ago. 2026. [5] Ollama. Execute modelos de linguagem localmente. Disponível em: <https://ollama.com/>. Acesso em: 08 ago. 2026. [6] Google. Gemma — modelos abertos. Disponível em: <https://ai.google.dev/gemma>. Acesso em: 08 ago. 2026. [7] Ministério da Saúde. LGPD no setor saúde. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/aceso-a-informacao/lgpd>. Acesso em: 08 ago. 2026. [8] ANPD. Regulamentações — Resoluções de proteção de dados. Disponível em: https://www.gov.br/anpd/pt-br/aceso-a-informacao/institucional/atos-normativos/regulamentacoes_anpd. Acesso em: 08 ago. 2026. [9] Odontiva. 10 KPIs Essenciais para Clínica Odontológica. 2026. Disponível em: <https://odontiva.com.br/blog/indicadores-desempenho-clinica-odontologica>. Acesso em: 08 ago. 2026. [10] PGFN/Receita Federal. Simples Nacional — orientações e tributação de serviços. Disponível em: <https://www.gov.br/pgfn/pt-br/cidadania-tributaria/por-assunto/simples-nacional>. Acesso em: 08 ago. 2026. [11] Ministério da Saúde/DATASUS. Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES). Disponível em: <https://cnes.datasus.gov.br/>. Acesso em: 08 ago. 2026. [12] Google. Colaboratory (Colab) — notebooks Python gratuitos. Disponível em: <https://colab.research.google.com/>. Acesso em: 08 ago. 2026.

Capítulo 4: Do Caos ao Comando — KPIs, Dashboards e Decisão

1. Introdução

Você tem o prontuário financeiro (Capítulo 2) e a bancada de IA (Capítulo 3). Falta o último instrumento de comando: o **painel** que transforma números soltos em decisão rápida. Este capítulo ensina a escolher os KPIs certos para uma clínica odontológica, a montar um dashboard gratuito (Looker Studio ou Power BI Desktop) e a usar a IA para interpretar, alertar e sugerir — sem nunca tirar a decisão das suas mãos.

O objetivo não é enfeitar: é reduzir o mês financeiro da clínica a uma tela que o dentista gestor lê em cinco minutos, todas as semanas. Você vai aprender quais indicadores importam (e quais são distração), como montar semáforos e alertas que guiam o olhar, e como fechar o livro com a disciplina final: conferência humana, conformidade (CNES, LGPD, normas do CFO) e um plano de ação de 90 dias.

Ao final, você será capaz de responder, diante do painel: a clínica está saudável? O que está piorando? Qual é a única coisa que eu devo fazer esta semana?

2. Explica

O painel de comando: menos é mais

Um dashboard eficaz para clínica odontológica não mostra 50 indicadores — mostra os poucos que descrevem a saúde do negócio e guiam a ação. A literatura de indicadores do setor aponta um conjunto central: faturamento bruto, ticket médio, inadimplência, custos fixos sobre a receita, margem de lucro e ocupação da agenda [1]. Cada um responde a uma pergunta de gestão: quanto entrou, quanto vale cada paciente, quanto está faltando receber, quanto custa operar, quanto sobra e quão cheia está a produção da clínica [1].

O princípio do painel é hierarquia: o olhar deve pousar primeiro no resultado (margem e caixa), depois nas alavancas (ticket médio, inadimplência, custos) e só então nos detalhes. Um painel sem hierarquia não é um painel — é um emaranhado que ninguém lê [1].

Os KPIs que importam na odontologia

Ticket médio — faturamento $\div$ pacientes atendidos: o valor médio que cada paciente agrega, termômetro da precificação [2][4]. **Inadimplência** — % dos valores vencidos não recebidos: a referência do setor é manter abaixo de 5%; acima de 10% exige ação imediata de cobrança [1]. **Custos fixos sobre a receita** — a faixa saudável é 40%–50% do faturamento bruto [1]. **Margem líquida** — resultado $\div$ receita líquida: clínicas eficientes operam entre 20% e 35% [3]. **Receita por cadeira** — faturamento $\div$ número de cadeiras: revela se a estrutura está subutilizada ou no limite [1]. **Ocupação da agenda** — horários preenchidos $\div$ disponíveis: o indicador de produção que explica, muitas vezes antes do financeiro, por que a margem caiu [1].

O dentista gestor não precisa decorar todos — precisa que o painel os mostre e que a IA explique as variações. O valor está na leitura conjunta: ticket médio caindo com ocupação estável indica queda de preço ou mix piorando; inadimplência subindo com receita estável indica problema de cobrança, não de demanda [1][2].

O capital de giro e a reserva

O painel também deve vigiar o oxigênio: o capital de giro, calculado como ativo circulante menos passivo circulante operacional [5]. A leitura semanal é simples — o colchão está acima de um mês de custo fixo? Se não, qualquer atraso de convênio vira emergência [5]. Uma linha no painel com o saldo do capital de giro em meses de custo fixo evita a recaída no caos do Capítulo 1.

O contexto: juros, inflação e benchmark

O painel ganha profundidade quando cruza os números internos com o contexto externo. A taxa de juros — publicada pelo Banco Central no Sistema Gerenciador de Séries Temporais [6] — define o custo de um financiamento de equipamento: com Selic alta, a decisão de comprar a terceira cadeira muda de conta [6]. A evolução da receita do setor de serviços, acompanhada mensalmente pelo IBGE [7], serve de benchmark: se a clínica cresce abaixo do setor, o problema é interno (captação, preço ou produtividade); se cresce acima, a estratégia está funcionando [7]. Essas séries são gratuitas, atualizadas e usáveis diretamente em planilhas [6][7].

A IA como copiloto do painel: interpretar e alertar

O dashboard mostra; a IA interpreta. Com o relatório mensal anonimizado, o assistente gratuito pode: explicar em linguagem natural por que a margem caiu (comparando os meses), sugerir as três causas mais prováveis, redigir o e-mail de cobrança amigável para os inadimplentes e preparar o resumo executivo para o sócio ou o banco. Os alertas podem ser simples: regras de semáforo (verde/amarelo/vermelho) calculadas na própria planilha, sem nenhum software pago [1].

Mas a IA tem limites que o gestor precisa conhecer: ela pode **sugerir** as causas, nunca **afirmar** — correlação não é causalidade, e a IA tende a ser confiante demais nas suas explicações [3]. E a responsabilidade final é humana: a decisão de cortar um procedimento, subir um preço ou contratar é do dentista, não do assistente [8]. Esse é o ponto central da ética da IA na gestão: a ferramenta amplia a capacidade de ver, não a autoridade de decidir [8][9].

A conformidade como pilar do comando

O painel financeiro da clínica opera dentro de um arcabouço regulatório que não pode ser ignorado. O estabelecimento precisa estar registrado no CNES, o cadastro nacional de estabelecimentos de saúde [10], cuja obrigatoriedade foi reiterada pela Anvisa também para as vigilâncias sanitárias [11]. Os dados dos pacientes são protegidos pela LGPD, com diretrizes do Ministério da Saúde e regulação da ANPD para o uso de IA [9]. E a atividade profissional segue as normas do Conselho Federal de Odontologia, que também disciplinam a publicidade de valores [12]. O comando financeiro saudável é o que respeita essas camadas: anonimização antes da nuvem, registro em dia e comunicação dentro das normas [9][12].

O plano de 90 dias

Com o painel montado, a gestão vira rotina de comando: nas primeiras quatro semanas, consolidar os dados e calibrar o painel; no segundo mês, atacar a pior alavanca (ticket, inadimplência ou custos); no terceiro mês, revisar preços com o custo por sessão e criar a reserva de capital de giro. A cada semana, uma reunião de cinco minutos do dentista com o painel — o novo fim de expediente.

3. Ilustra

O painel de comando da clínica é o contraponto do caos do Capítulo 1: onde antes havia um caderno de anotações e um extrato bancário misturado com contas pessoais, agora há uma tela única, com semáforos, tendências e um número em destaque: o resultado do mês.

Como Gestor de Clínica Odontológica, você vai ler essa tela toda semana. O diagrama abaixo mostra a anatomia do painel — e como cada bloco se conecta à decisão.

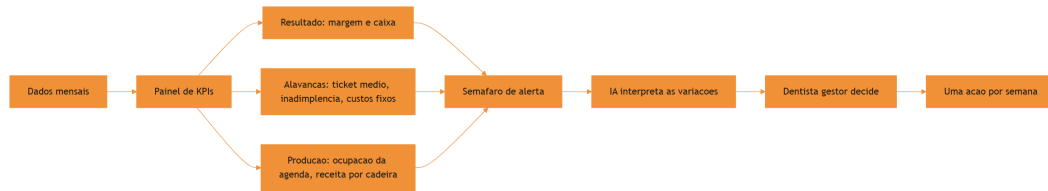


Figura 4: Anatomia do painel de KPIs da clínica odontológica

4. Técnica

Montando o painel de KPIs com Python

Antes do dashboard visual, o cálculo dos KPIs mensais roda em Python — dentro do assistente ou no Colab:

```
import pandas as pd

# Dados mensais (arquivo kpis_mensais.csv do capítulo 2)
df = pd.read_csv("kpis_mensais.csv")

# KPIs por mes
df["margem"] = (df["resultado"] / df["receita_liquida"]) * 100
df["custo_fixo_pct"] = (df["custo_fixo"] / df["receita_bruta"]) * 100
df["ticket_medio"] = df["receita_bruta"] / df["pacientes"]
df["receita_por_cadeira"] = df["receita_bruta"] / df["cadeiras"]

print(df[["mes", "margem", "custo_fixo_pct", "ticket_medio",
"receita_por_cadeira"]].to_string(index=False))

# Semáforo (regras de mercado do setor)
def semaforo(margem, inadimplencia):
    if margem >= 20 and inadimplencia < 5:
        return "VERDE"
    if margem >= 15 and inadimplencia < 10:
        return "AMARELO"
    return "VERMELHO"

ultimo = df.iloc[-1]
```

```
print(f"\nSemáforo do mes: {semaforo(ultimo['margem'],  
ultimo['inadimplencia'])}")
```

O semáforo na planilha (fórmulas)

Para quem prefere o painel na própria planilha, o semáforo vira fórmula:

No Excel, crie uma coluna "Status" que retorne "Verde", "Amarelo" ou "Vermelho" conforme: Verde se margem $\geq 20\%$ E inadimplencia $< 5\%$; Amarelo se margem $\geq 15\%$ E inadimplencia $< 10\%$; Vermelho caso contrario. Use a funcao SE (IF) com E (AND), referenciando as celulas de margem e inadimplencia. Formate com formatacao condicional: verde, amarelo e vermelho.

O dashboard no Looker Studio

Para o painel visual gratuito, o Looker Studio (Google) aceita o CSV da planilha como fonte:

Monte um dashboard no Looker Studio com: (1) um scorecard com o resultado do ultimo mes; (2) um grafico de linha com a evolucao da margem por mes; (3) um grafico de barras com o ticket medio por mes; (4) uma tabela com inadimplencia e custos fixos por mes; (5) um filtro por periodo. Conecte a fonte como upload de CSV.

No Power BI Desktop (gratuito para uso local), a medida de margem em DAX:

```
Margem Liquida = DIVIDE(SUM('kpis'[resultado]),  
SUM('kpis'[receita_liquida]))
```

O alerta de inadimplência

A inadimplência é o KPI que mais exige ação imediata. Monte a lista de cobrança com a IA:

Tenho a lista anonimizada de pacientes com valores vencidos (colunas: codigo, valor, dias de atraso, procedimento). Classifique em tres grupos: (1) atraso ate 15 dias - lembrete amigavel por WhatsApp; (2) 15 a 45 dias - ligacao da recepcao oferecendo renegociacao; (3) acima de 45 dias - cobranca formal. Para cada grupo, redija a mensagem-tipo, com tom profissional e respeitoso.

A interpretação mensal com IA

No fim do mês, o resumo executivo sai em minutos:

Compare os dados dos últimos dois meses (anexados em formato CSV): receita bruta, ticket médio, inadimplência, custos fixos, margem e ocupação da agenda. Identifique as três variações mais relevantes, sugira a causa mais provável de cada uma (sem afirmar como fato) e proponha uma ação prática para cada. Termine com um parágrafo pronto para enviar ao sócio, em tom executivo.

A decisão de abrir a terceira cadeira

Um dos momentos em que o painel decide tudo: a hora de investir. A pergunta “a clínica aguenta a terceira cadeira?” tem resposta no painel, não no entusiasmo. O raciocínio em cinco passos: (1) qual a receita média por cadeira atual? (2) qual a ocupação da agenda — se está acima de 85%, há demanda represada; (3) qual o custo mensal de uma cadeira nova (equipamento parcelado + depreciação + aluguel de área + mais um auxiliar)? (4) quantos atendimentos a mais por mês a cadeira precisa gerar para cobrir o custo? (5) com a Selic atual — a série do Banco Central [6] — o financiamento vale mais que o custo de oportunidade do caixa? O painel transforma a decisão de investimento em uma conta de cinco linhas, e a IA ajuda a montar a conta sem decidir por você.

O alerta automático por e-mail

O painel vira sistema de alerta quando a planilha manda o resumo automaticamente. No Google Sheets, um script simples dispara o e-mail semanal com o semáforo:

```
// Exemplo de rotina (Google Apps Script): envia o resumo semanal
function enviarResumoSemanal() {
  var sheet = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().getSheetByName("KPIs");
  var ultima = sheet.getLastRow();
  var margem = sheet.getRange(ultima, 3).getValue();
  var inad = sheet.getRange(ultima, 4).getValue();
  var status = (margem >= 20 && inad < 5) ? "VERDE" :
               (margem >= 15 && inad < 10) ? "AMARELO" : "VERMELHO";
  MailApp.sendEmail(
    Session.getActiveUser().getEmail(),
    "Resumo semanal da clinica - " + status,
    "Margem: " + margem + "% | Inadimplencia: " + inad + "%"
  );
}
```

O alerta não substitui a leitura do gestor — ele garante que a leitura aconteça toda semana, mesmo na correria da clínica.

A reunião de cinco minutos com o painel

A rotina final do comando é uma reunião semanal de cinco minutos entre o dentista e o painel, com quatro perguntas fixas: o resultado melhorou ou piorou? Qual alavanca mudou mais (ticket, inadimplência, custos, ocupação)? O que a IA aponta como causa provável — e eu concordo? Qual é a única ação desta semana? Cinco minutos por semana com resposta às quatro perguntas é a diferença entre o dentista gestor e o dentista que administra no susto.

O plano de 90 dias, em detalhe

Semana	Foco	Ação concreta
1–4	Consolidação	Alimentar <code>caixa_clinica.csv</code> , <code>kpis_mensais.csv</code> e o DRE; calibrar o painel
5–8	A pior alavanca	Atacar o indicador mais fora da faixa (ticket, inadimplência ou custos)
9–12	Preços e reserva	Revisar precificação com custo por sessão; criar reserva de 1 mês de custo fixo

Cada linha da tabela tem um critério de conclusão mensurável: o painel fecha o mês com todos os campos preenchidos (semanas 1–4); o indicador-alvo se move ao menos um passo em direção à faixa saudável (semanas 5–8); a reserva atinge o alvo e o preço de dois procedimentos é revisado (semanas 9–12).

O checklist semanal do comando

A reunião de cinco minutos funciona melhor com um checklist fixo. Imprima (ou fixe ao lado do painel) esta sequência:

1. O resultado do mês (margem e caixa) melhorou ou piorou frente ao mês anterior?
2. Qual alavanca se moveu mais: ticket médio, inadimplência, custos fixos ou ocupação?
3. O que a IA aponta como causa provável — e eu concordo com essa leitura?
4. Há algum alerta vermelho (inadimplência > 10%, margem < 15%, capital de giro < 1 mês)?

5. Qual é a única ação desta semana?
6. Registro a ação no `kpis_mensais.csv` para avaliar o efeito no mês seguinte.

O checklist transforma a leitura do painel de evento em hábito — e o hábito é o que sustenta a gestão quando a correria da clínica volta [1].

A análise de variação com a IA

Quando o indicador muda, o gestor quer a explicação — mas uma explicação de qualidade. O prompt abaixo força a IA a mostrar o raciocínio e a distinguir causa de correlação:

Minha margem caiu de 22% para 16% entre os dois ultimos meses.
Dados (CSV anexado): receita, ticket medio, inadimplencia, custos fixos, ocupacao da agenda. Analise e responda:

1. Quantifique a contribuicao de cada variavel para a queda (em pontos percentuais), mostrando o calculo.
2. Distinga o que e causa provavel do que e apenas correlacao.
3. Aponte o que voce NAO pode concluir com esses dados.
4. Proponha duas acoes de teste para a semana, com metrica de verificacao em 30 dias.

A resposta com contribuição quantificada, separação entre causa e correlação e o reconhecimento do que não se pode concluir é o padrão de qualidade da bancada — o mesmo que o dentista exigiria de um bom assistente clínico.

Os dados que ainda não são financeiros

O painel financeiro conversa com dois conjuntos de dados que a clínica já produz: a agenda (ocupação, faltas, desistências) e o prontuário (procedimentos por tipo, recorrência de tratamentos). A ocupação da agenda explica a receita antes mesmo de ela cair: se a taxa de faltas subir de 5% para 12%, o caixa de quatro semanas depois sentirá o efeito. O mix de procedimentos explica o ticket médio: se o prontuário mostra crescimento de limpezas e queda de próteses, o ticket vai cair antes de aparecer no painel. O gestor atento conecta as pontas: agenda e prontuário são indicadores antecedentes; caixa e margem são consequentes [1].

O registro do aprendizado mensal

No fim de cada mês, o gestor registra uma linha no `kpis_mensais.csv` com os números e uma linha de texto com a leitura: o que mudou, o que a IA apontou, o que ele decidiu e o que vai observar. Esse registro é o que transforma a gestão em aprendizado acumulado — em doze meses, o dentista gestor tem um histórico que nenhum curso ensina: a memória financeira da própria clínica, com as causas de cada variação documentadas [1][9].

As métricas que comprovam o método

Todo o livro pode ser resumido em um pequeno conjunto de metas de verificação — as métricas que mostram, em números, que a gestão funcionou:

Meta	Como medir	Prazo razoável
Margem líquida $\geq 20\%$	DRE mensal	6 meses de método
Inadimplência $< 5\%$	contas a receber vencidas	3–6 meses de cobrança ativa
Ticket médio em alta	faturamento $\div$ pacientes	trimestral
Capital de giro ≥ 1 mês de custo fixo	ativo circulante – passivo circulante [5]	6 meses de reserva programada
Fim de expediente ≤ 15 min	cronômetro da rotina	imediato

A última linha é a mais reveladora: quando a rotina do fim de expediente — alimentar o caixa, conferir com a IA, ler o painel — cabe em quinze minutos, o método virou hábito, e o hábito virou gestão [1].

O fechamento do arco: da cadeira ao comando

Este capítulo encerra o arco que começou no primeiro fim de expediente: o dentista que era refém da agenda agora comanda o negócio a partir de uma tela. O prontuário financeiro (Capítulo 2), a bancada de IA (Capítulo 3) e o painel de comando (Capítulo 4) formam o sistema completo de gestão — e cada peça só funciona porque a anterior existe: sem caixa organizado não há DRE confiável; sem anonimização não há IA segura; sem painel não há decisão rápida. O sistema não exige investimento em software: exige disciplina, uma planilha e as ferramentas gratuitas que este livro apresentou [1][9].

O que este livro não é

Para não restar dúvida: este livro não ensina odontologia, não substitui contador e não promete enriquecimento rápido. Ele ensina uma coisa só — um sistema de gestão financeira para clínica odontológica construído com ferramentas gratuitas e a disciplina do fim de expediente. O resto é consequência: números claros, decisões com critério e um negócio que o dentista entende de verdade.

Kit de verificação do capítulo

Ao final, você deve ter: (1) os KPIs dos últimos meses calculados com semáforo; (2) o dashboard visual (Looker Studio ou Power BI) alimentado com os dados; (3) a política de cobrança em três níveis; e (4) o primeiro resumo executivo gerado pela IA e conferido por você.

5. Aplica

A cena do caos

É segunda-feira, e o Dr. Paulo está com três frentes abertas ao mesmo tempo: o banco quer saber por que o faturamento caiu, a auxiliar relata que três pacientes reclamaram de preço e a contadora avisou que o pró-labore do mês não cabe no caixa. O Dr. Paulo não tem nenhum número na frente — ele responde ao banco com “a clínica está bem”, à auxiliar com “reajustamos no próximo mês” e à contadora com “tira do cartão”. Três decisões, zero dados: o caos do Capítulo 1, agora em escala de gestão.

A mesma cena, com o método

O Dr. Paulo abre o painel. O semáforo está amarelo: margem 16%, inadimplência 8,5%. O gráfico de ticket médio mostra queda nos últimos três meses. Ele pede à IA que compare os meses e sugira causas: a IA aponta o mix de procedimentos — cresceu o volume de limpezas (ticket baixo) e caiu o de próteses — e uma inadimplência concentrada em parcelamentos de 2025. O Dr. Paulo decide duas ações: revisa o plano de reabilitação (aumento de próteses no mix, com justificativa de custo por sessão) e dispara a cobrança em três níveis para a carteira vencida. Trinta dias depois, o ticket médio subiu 12% e a inadimplência caiu para 6%. O banco recebe o resumo executivo com números — e o Dr. Paulo dorme melhor.

Exercício do comando

1. Calcule os KPIs dos seus últimos três meses (margem, ticket médio, inadimplência, custos fixos, receita por cadeira).
2. Monte o semáforo do último mês com as regras do setor.
3. Crie o dashboard gratuito (Looker Studio ou Power BI) e conecte os dados.
4. Gere com a IA o resumo executivo do mês e confira cada número.
5. Escreva a sua única ação da semana com base no painel.

O exercício corrige o rumo

A virada final do livro é a mais importante: o painel não existe para ser bonito — existe para reduzir a distância entre o dado e a decisão. O dentista gestor não decide no escuro, não decide na emoção e não terceiriza a decisão para a IA [8]. Ele olha o painel, confere com a IA, decide com o próprio critério e age — uma ação por semana, todo mês, todo ano.

6. Conclusão

Este capítulo fechou o arco do livro: do caos do fim de expediente (Capítulo 1) aos números organizados (Capítulo 2), com a IA gratuita na bancada (Capítulo 3) e, agora, o painel de comando (Capítulo 4). Você conheceu os KPIs que importam — ticket médio, inadimplência, custos fixos, margem e receita por cadeira [1][2][3][4] —, o contexto externo de juros e benchmark [6][7], a reserva de capital de giro [5] e as camadas de conformidade que sustentam tudo [9][10][11][12]. E, acima de tudo, você aprendeu a regra que governa o livro inteiro: a IA amplia a visão, o humano decide [8].

O plano de 90 dias está nas suas mãos: consolide os dados no primeiro mês, ataque a pior alavanca no segundo, revise preços e reserve no terceiro. O fim de expediente nunca mais será o mesmo — agora ele tem um painel, um copiloto e um comando.

7. Referências

- [1] Odontiva. 10 KPIs Essenciais para Clínica Odontológica. 2026. Disponível em: <https://odontiva.com.br/blog/indicadores-desempenho-clinica-odontologica>. Acesso em: 08 ago. 2026.
- [2] Dental Office. Dentista: como calcular o ticket médio da sua clínica odontológica? 2024. Disponível em: <https://www.dentaloffice.com.br/ticket-medio/>. Acesso em: 08 ago. 2026.
- [3] Sanders, L. Como funciona a margem de lucro na odontologia? Simples Dental, 2025. Disponível em: <https://www.simplesdental.com/blog/margem-de-lucro-na-odontologia/>. Acesso em: 08 ago. 2026.
- [4] Clinicorp. Como calcular o ticket médio na odontologia? Aprenda agora. 2025. Disponível em: <https://www.clinicorp.com/post/calcular-ticket-medio-odontologia>. Acesso em: 08 ago. 2026.
- [5] Angelus. Como ter uma boa gestão financeira do consultório odontológico? 2024. Disponível em: <https://angelus.ind.br/pt-br/blog/gestao-financeira-de-consultorio-odontologico/>. Acesso em: 08 ago. 2026.
- [6] Banco Central do Brasil. Sistema Gerenciador de Séries Temporais (SGS). Disponível em: <https://www3.bcb.gov.br/sgspub/>. Acesso em: 08 ago. 2026.
- [7] IBGE. Pesquisa Mensal de Serviços (PMS). Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/servicos/9229-pesquisa-mensal-de-servicos.html>. Acesso em: 08 ago. 2026.
- [8] ANPD. Regulamentações — Resoluções de proteção de dados (uso de IA). Dispo-

nível em: https://www.gov.br/anpd/pt-br/aceso-a-informacao/institucional/atos-normativos/regulamentacoes_anpd. Acesso em: 08 ago. 2026. [9] Ministério da Saúde. LGPD no setor saúde. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/aceso-a-informacao/lgpd>. Acesso em: 08 ago. 2026. [10] Ministério da Saúde/DATASUS. Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES). Disponível em: <https://cnes.datasus.gov.br/>. Acesso em: 08 ago. 2026. [11] Anvisa. Anvisa esclarece obrigatoriedade de cadastro das vigilâncias sanitárias e em saúde no CNES. 2025. Disponível em: <https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2025/anvisa-esclarece-obrigatoriedade-de-cadastro-das-vigilancias-sanitarias-e-em-saude-no-cnes>. Acesso em: 08 ago. 2026. [12] Conselho Federal de Odontologia. Portal institucional — normas e resoluções da profissão. Disponível em: <https://website.cfo.org.br/>. Acesso em: 08 ago. 2026.

O Dentista Gestor: Finanças de Clínica com IA

O cirurgião-dentista é formado para clinicar, não para gerir. Entre a última consulta do dia e a primeira do amanhã existe um expediente invisível: o dos números. Este livro ensina o dentista dono de clínica a assumir esse expediente com ferramentas de IA gratuitas — planilhas, chats e dashboards — para transformar caos financeiro em comando. Cada capítulo combina teoria curta, exemplo prático, código executável e referências verificáveis.

Heverton Eduardo Peres